정책연구용역사업 중간진도보고서

<table>
<tr><td>연구사업번호</td><td colspan="3">2023-11-022</td><td>발주부서</td><td colspan="2">만성질환관리과</td></tr>
<tr><td>보안 분류</td><td colspan="3">□ 보안 ■ 일반</td><td>결과공개여부</td><td colspan="2">■ 가 □ 부</td></tr>
<tr><td>연구사업명</td><td colspan="6">지역 간 건강격차 해소사업 기술지원 및 지역사회 안착 방안 연구</td></tr>
<tr><td>연구기간</td><td colspan="3">2023. 08. 01. ~ 2023. 12. 31.</td><td>연 구 비</td><td colspan="2">86,500 천원</td></tr>
<tr><td rowspan="6">주관 연구기관
연구책임자
(총괄책임자)</td><td>성 명</td><td colspan="2">현 재 호</td><td>전화번호</td><td colspan="2">02-6917-5555</td></tr>
<tr><td>이메일주소</td><td colspan="2">hyunjaeho@tenopa.co.kr</td><td>휴대전화</td><td colspan="2">010-2382-0606</td></tr>
<tr><td>기관주소</td><td colspan="5">서울특별시 강남구 역삼로 212 동아빌딩 4층</td></tr>
<tr><td>소속/부서</td><td colspan="2">혁신사업본부</td><td>직위/전공</td><td colspan="2">경영과학</td></tr>
<tr><td>실무담당자</td><td colspan="2">허제</td><td>연락처</td><td colspan="2">02-6917-5546</td></tr>
<tr><td>연구참여자</td><td colspan="6">총 7 명
[연구책임자 1명, 연구원 2명, 연구보조원 3명, 보조원 1명]</td></tr>
<tr><td>세부연구사업
여부</td><td colspan="3">해당( ), 해당없음(●)
※ 해당부분에 ●표기</td><td>세부연구사업 수</td><td colspan="2">총 0 개</td></tr>
</table>

붙임과 같이 국립보건연구원 정책연구용역사업에 대한 중간진도보고서를 제출합니다.

2023 년 10 월 31 일

주관연구책임자 현 재 호 (서명 또는 인)

붙임 1. 중간진도보고서

질 병 관 리 청 장 귀하

목 차

제1장 연구수행 내용 ····· 1

1. 종결사업 대상 지역 간 건강격차 해소사업 분석 ····· 1

가. 건강격차 해소사업 현황 ····· 1

나. 종결사업 대상 연구책임자 심화인터뷰 추진 결과 ····· 16

다. 종결사업 성과분석 ····· 24

라. 종결사업 우수사례 선정 ····· 42

2. 국외 건강격차 해소 우수사례 조사·분석 ····· 44

가. 영국의 건강격차 정책과 사업 현황 ····· 44

나. 일본의 건강격차 정책과 사업 현황 ····· 47

3. 지역사회 건강격차 해소사업 추진 기술지원 ····· 55

4. 지역사회 건강격차 해소 보건사업 추진 매뉴얼 개발 ····· 56

제2장 연구용역사업의 진척도 ····· 55

제3장 과제수행에 따른 문제점 및 개선방안 ····· 57

제4장 연구 분담표 ····· 58

제5장 중요 연구변경 사항 등 기재 ····· 59

제6장 연구비 집행 내역 ····· 60

표 목차

<표 1> 권역별 사업 현황('17-'23년) ····· 1
<표 2> 건강격차 해소 추진(중) 사업 목록(지역 간, 지역 내, 소지역 전체) ····· 1
<표 3> 종료사업 현황 ····· 3
<표 4> 종료사업 연차별 연구 상세 - 금연시도율 ····· 4
<표 5> 종료사업 연차별 연구 상세 - 걷기실천율 ····· 7
<표 6> 종료사업 연차별 연구 상세 - 이환 ····· 10
<표 7> 종료사업 연차별 연구 상세 – 그 외 ····· 13
<표 8> 심화인터뷰 대상자 목록 ····· 16
<표 9> 경기 양평군-광주시 현재흡연자의 금연시도율 ····· 24
<표 10> 전북 김제시-정읍시 현재흡연자의 금연시도율 ····· 25
<표 11> 서울 동대문구-광진구 현재흡연자의 금연시도율 ····· 26
<표 12> 인천 미추홀구-연수구 현재흡연자의 금연시도율 ····· 27
<표 13> 현재흡연자의 금연시도율에 따른 중재전략 비교 ····· 28
<표 14> 강원 영월군-삼척시 걷기실천율 ····· 30
<표 15> 경남 의령군-함암군 걷기실천율 ····· 31
<표 16> 전북 임실군-고창군 걷기실천율 ····· 32
<표 17> 걷기실천율에 따른 중재전략 비교 ····· 33
<표 18> 강원 인제군-양구군 비만율 ····· 34
<표 19> 인천 옹진군-부평구 비만율 ····· 35
<표 20> 비만율에 따른 중재전략 비교 ····· 36
<표 21> 부산 동구 등-남구 고위험음주율 ····· 37
<표 22> 충남 금산군-공주시 고위험음주율 ····· 38
<표 23> 고위험음주율에 따른 중재전략 비교 ····· 39
<표 24> 광주광역시의 남구와 서구의 당뇨병 진단 경험율 ····· 40
<표 25> 대구 남구와 동구의 중증도이상 신체활동실천율 ····· 40
<표 26> 기타 중재전략 비교 ····· 41
<표 27> 종료사업의 주요 지표별 변화 ····· 42
<표 28> 국토교통성 우수 건강 도시 선정과 선정 이유 ····· 47
<표 29> 스마트웰네스시티 다카이시 기본계획 ····· 48
<표 30> 건강수명의 연장과 건강격차의 축소 목표 ····· 52
<표 31> 영양·식생활 개선 목표 ····· 52
<표 32> 신체활동·운동 개선 목표 ····· 53
<표 33> 휴식·수면 개선 목표 ····· 53
<표 34> 음주 개선 목표 ····· 53
<표 35> 흡연 개선 목표 ····· 54
<표 36> 사회와의 연결·마음 건강 유지 및 향상에 대한 개선 목표 ····· 54
<표 37> 자연스럽게 건강해지는 환경 조성 개선 목표 ····· 54
<표 38> 월별 추진 일정 ····· 57
<표 39> 주요 연구 내용 변경 사항 ····· 59

그림 목차

[그림 1] 경기 양평군-광주시 현재흡연자의 금연시도율 ····· 24
[그림 2] 전북 김제시-정읍시 현재흡연자의 금연시도율 ····· 25
[그림 3] 서울 동대문구-광진구 현재흡연자의 금연시도율 ····· 26
[그림 4] 인천 미추홀구-연수구 현재흡연자의 금연시도율 ····· 27
[그림 5] 강원 영월군-삼척시 걷기실천율 ····· 30
[그림 6] 경남 의령군-함암군 걷기실천율 ····· 31
[그림 7] 전북 임실군-고창군 걷기실천율 ····· 32
[그림 8] 강원 인제군-양구군 비만율 ····· 34
[그림 9] 인천 옹진군-부평구 비만율 ····· 35
[그림 10] 부산 동구 등-남구 고위험음주율 ····· 37
[그림 11] 충남 금산군-공주시 고위험음주율 ····· 38
[그림 12] 니가타현 미쓰케시의 건강도시 정책 사례 ····· 48
[그림 13] 오사카 다카이시시의 건강한 도시만들기 ····· 49
[그림 14] 야와타시 건강도시 정책 진행 구성 ····· 49
[그림 15] 교토 야와타시의 건강한 도시만들기 ····· 50
[그림 16] 연구자 대상 네트워크 구축 ····· 55

제1장 연구수행 내용

1. 종결사업 대상 지역 간 건강격차 해소사업 분석

가. 건강격차 해소사업 현황

○ 2023년 현재, 14개의 과제가 종료되었고 11개 과제가 진행되고 있음

- 종료사업 14개, 현재 진행중인 사업 15개(소지역 포함)

<표 1> 권역별 사업 현황('17-'23년)

수도권	강원권	충청권	호남권	대경권	동남권	제주권
8	4	3	6	2	6	-

<표 2> 건강격차 해소 추진(중) 사업 목록(지역 간, 지역 내, 소지역 전체)

지표 구분		사업지역(대조지역)	권역	연구자 정보	
대	소			기관명	성명
□ 건강행태					
신체활동	걷기실천율	부산 북구(수영구)	부산광역시	동서대학교	이효영
		청양군(금산군)	충청남도	㈜테크노베이션파트너스	현재호
		영월군(삼척시)	강원도	연세대학교	공인덕
		의령군(함암군)	경상남도	경상대학교	박기수
		임실군(고창군)	전라북도	원광대학교	이영훈
	건강생활실천율	서울 마포구(송파구)	서울특별시	삼육대학교	손애리
	신체활동실천율	대구 남구(동구)	대구광역시	경북대학교	홍남수
흡연	금연시도율	김천시(문경시)	경상북도	영남대학교	황태윤
		양평군(광주시)	경기도	한양대학교	최보율
		김제시(정읍시)	전라북도	원광대학교	오경재
		서울 동대문구(광진구)	서울특별시	건국대학교	김형수

지표 구분		사업지역(대조지역)	권역	연구자 정보	
대	소			기관명	성명
	현재흡연율	원주시(춘천시)	강원도	원주연세대학교	이광수
		인천 미추홀구(연수구)	인천광역시	인하대학교	이훈재
	남자현재흡연율	완도군(진도군)	전라남도	전남대학교	권순석
음주	고위험 음주율	서울 강북구(강서구)	서울특별시	이화여자대학교	제갈정
		인천 옹진군	인천광역시	인하대학교 산학협력단	박수정
		부산 동구·중구·서구·영도구(남구)	부산광역시	동서대학교	이효영
		금산군(공주시)	충청남도	충남대학교	남해성
	고위험음주 및 음주관련 폐해	서울 중랑구	서울특별시	가톨릭대학교	조선진
구강위생	칫솔질 실천율	홍성군(횡성군)	강원도	원주연세대학교	김남희
검진	암검진율	부산 수영구(해운대)	부산광역시	부산대학교	김창훈
정신건강	우울감 경험률	대전 대덕구(유성구)	대전광역시	을지대학교	최경숙
□ **건강결과**					
발생률	간암 발생율	남해군	경상남도	경상국립대학교	박기수
	고혈압진단 경험률 및 고혈압 진단 경험자의 치료율	익산시(군산시)	전라북도	원광대학교	이영훈
	당뇨병 관리 관련 지표	광주 남구(서구)	광주광역시	조선대학교	류소연
	심근경색증 및 뇌졸중 조기증상 인지율	무주군(진안군)	전라북도	원광대학교	오경재
유병률	비만율	인제군(양구군)	강원도	강원대학교	조희숙
		인천 옹진군(부평구)	인천광역시	가천대학교	문종윤
-	만성질환 예방관리와 건강행태 개선	사천시	경상남도	인제대학교	전진호

: '23년 기준, 추진중인 사업

□ 종료 건강격차 해소사업 분석

- 총 14개의 종료사업에 대하여 각 연도별 연구 추진 방법에 따른 주요 내용과 중재사업 전략과 평가방법을 지표별로 정리

<표 3> 종료사업 현황

No.	종료사업명	연도	연구책임자	연구기관
1	경기도의 양평군과 광주시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘17-’19	최보율	한양대학교
2	전라북도의 김제시와 정읍시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘18-’20	오경재	원광대학교
3	서울특별시의 동대문구와 광진구 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘19-’21	김형수	건국대학교
4	인천광역시의 미추홀구와 연수구 간 현재흡연율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘19-’21	이훈재	인하대학교
5	강원도의 영월군과 삼척시 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘17-’19	공인덕	연세대학교
6	경상남도의 의령군과 함안군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘18-’20	박기수	경상대학교
7	전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘20-’22	이영훈	원광대학교
8	광주광역시의 남구와 서구 간 당뇨병 관리 관련 지표 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘17-’19	류소연	조선대학교
9	강원도의 인제군과 양구군 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘19-’21	조희숙	강원대학교
10	인천광역시의 옹진군과 부평구 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘20-’22	문종윤	가천대학교
11	부산광역시의 동구·중구·서구·영도구와 남구 간 고위험음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘18-’20	이효영	동서대학교
12	충청남도의 금산군과 공주시 간 고위험음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘18-’20	남해성	충남대학교
13	대구광역시의 남구와 동구 간 중등도 이상 신체활동 실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘19-’21	홍남수	경북대학교
14	부산광역시의 수영구와 해운대 간 암검진율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	‘20-’22	김창훈	부산대학교

<표 4> 종료사업 연차별 연구 상세 - 금연시도율

구분	경기도의 양평군과 광주시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	전라북도의 김제시와 정읍시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	서울특별시의 동대문구와 광진구 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	인천광역시의 미추홀구와 연수구 간 현재흡연율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발
1차년도				
지표현황분석	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)
원인도출모델	□ CSDH, 건강행태이론, 사회적 네트워크, MPOWER	□ CSDH, 로직모델, 사회관계모형, MPOWER	□ CSDH, 로직모델, 사회관계모형, MPOWER	□ 건강믿음모형, 사회생태학적모형, MPOWER
사업/대조지역 비교	□ CHS 결과비교	□ 인구수, 면적, 행정지역, 보건기관수 □ 사회/환경/지리적특성 □ 흡연관련지표비교	□ CHS 결과비교	□ 건강프로파일 DB 주요현황비교
지역사회 가용자원과 역량 파악	□ 조례 및 금연사업현황파악	□ 조례 및 금연사업현황파악	□ 조례 및 금연사업현황파악	□ 보건소 금연사업의 다각화
원인규명 활용자료	□ 경기도 시군 금연정책(조례 및 시행규칙) □ 경기도 금연사업 자료분석(실적보고시스템, 금연사업평가자료, 금연사업 투입인력자료) □ 금연클리닉 이용자 등록자료 □ CHS자료 □ 건강프로파일 DB □ 보건의료인의 금연권구와 금연진료행태조사(사회적지지 파악) □ 지역사회 건강서비스 관련 네트워크 조사 □ 읍면동 단위 사회자본조사	□ '10~'16 CHS원시자료 및 소지역 분석 □ 지역사회 기관단체 네트워크 조사 □ 사회관계망조사: 건강서비스 관련 정보 교류관계망, 건강서비스 제공을 위한 대상자 의뢰 관계망, 건강서비스 제공을 위한 협력관계망 □ 담배 판매업소 및 담배농가 현황 □ 금연정책 및 사업비교 □ 금연치료 의료기관 현황 비교	□ CHS 통합자료분석 □ 금연정책 및 조례분석 □ 금연사업 분석(논리모형) □ 담배 판매업소 분석 □ 사회연결망 네트워크조사	□ CHS 자료분석 □ 건강프로파일DB □ FGI □ 행정자료 □ 전국 보건소 대상 자체설문조사 등을 통한 건강격차에 대한 29개의 가설도출
지역추진위원회 구성 및 운영	(2차년도)	(3차년도)	□ 확인사항 없음	□ 확인사항 없음

2차년도				
심층분석 활용자료	▯ 1차년도와 유사	▯ 보건소 금연클리닉 이용자분석('15-'18) ▯ 지역사회 흡연자 조사분석 ▯ 신규금연시도자조사 ▯ 사업장/기관금연환경조사 ▯ 소지역 금연환경조사 ▯ 흡연자/가족 심층인터뷰(FGI)	▯ 확인사항 없음	▯ 건강신념모형에 근거한 흡연자의 흡연인식조사 ▯ 일반화를 위한 전국 시군구 건강프로파일 DB활용분석 ▯ 행정자료, 자문 및 워크샵(가설판정-채택/잠정채택/기각/잠정기각/판단유보)
지역사회와 격차원인 정보공유	▯ 보건소장 간담회, 군수/면장/시장/읍장간담회, 주민설명회	▯ 간담회(사업지역 및 대조지역별 2회) 및 지역추진위원회(3회)	▯ 확인사항 없음	▯ 중재모형의 타당성 및 추진가능성 등에 대해 유관기과의 협력체계 구축
타 시군구 지표관련 보건사업 고찰	▯ 대조지역의 금연조례 및 금연사업자료를 비교함	▯ 대조지역의 금연조례 및 금연사업자료를 비교함	▯ 대조지역의 금연조례 및 금연사업자료를 비교함	▯ 대조지역의 금연조례 및 금연사업자료를 비교함
사회생태학적 모형 기반 전략도출	▯ 사회생태학적 모형에 기반한 전략 도출함	▯ 사회생태학적 모형에 기반한 전략 도출함	▯ 사회생태학적 모형에 기반한 전략 도출함	▯ 사회생태학적 모형에 기반한 전략 도출함
도출원인과 중재사업 간 연계성	▯ 격차원인을 기반으로 중재전략을 도출하고 이를 반영하여 시범사업을 계획함	▯ 중재원인분석 및 요구도 조사 결과반영하여 보건소 내 통합건강증진사업, 만성질환 관리사업과 금연사업을 연계하고 김제시의 강점으로 파악된 금연클리닉의 접근성과 이용률 향상을 위한 프로그램을 개발함 ▯ 소지역분석결과,현재흡연율이높고지역사회자원연계가가능하며소지역리더들과보건기관의참여의지가높은소지역을선정함	▯ 격차의 원인보다는 인식변화에 중점을 두어 전략도출 ▯ 인식변화유도와 금연환경조성을 통해 금연의지를 고취 시키고 금연지지 체계를 마련하여 금연시도를 유도 하고자하였음	▯ 원인에 따른 중재모형을 제시함 (격차원인중비교적단기간동안의시범사업을 통해 개선이 가능해야하며,현장적용기간이5-6개월도 되지않으므로기존경험과네트워크를활용할수있는영역,보건기관에서수용이 가능한모형을제안, 비대면 플랫폼과컨텐츠활용전략구사및금연환경 확산을강조하고자함)
중재사업 내용	▯ 사업대상 및 내용, 사업수행 조직, 목표 및 기대효과 위주로 포함됨	▯ 사업대상 및 내용, 사업수행 조직, 목표 및 기대효과, 기존 사업과의 연계위주로 포함됨	▯ 사업대상 및 내용, 사업수행 조직, 목표 및 기대효과, 기존 사업과의 연계위주로 포함됨	▯ 사업대상 및 내용, 사업수행 조직, 목표 및 기대효과 위주로 포함됨
중재사업 평가계획	▯ 신규사업에 대한 과정평가(지역담당자) ▯ 네트워크조사를통한영향평가 ▯ 금연사업실적보고자료를통한산출평가 ▯ 지표변화를통한결과평가(4년단위)	▯ 과정평가 양식개발	▯ 개선안에는 평가계획 수립되어있으나 시범사업수행 계획시 수립여부는 파악되지 않음	▯ 투입/산출/결과모형에 따른 성과지표와 평가방법 제안함

3차년도				
중재사업 수행과정을 지역과 함께 모니터링	▯ 신규사업의 경우 사업진행과 함께 과정평가를 ▯ 수행하며 모니터링함	▯ 간담회 및 지역추진위원회 진행시 함께 ▯ 모니터링	▯ 확인사항 없음	▯ 중재모형의 타당성 및 추진가능성 등에 대해 ▯ 유관기과의 협의진행
중재사업 평가	▯ 금연환경과 금연문화의 조성관련 관계망 전후비교: 건강서비스 관련 정보교류관계망, 건강서비스 제공을 위한 대상자 의뢰 관례망, 건강서비스 제공을 위한 협력 관계망 ▯ 금연환경과금연문화의인지도조사:기관,단체,보건의료기관, 주민대상	▯ 금연캠프참가자의 평가 ▯ 지역주민대표평가(1년전에비해개선되었다고생각하십니까?)	▯ 금연클리닉 등록자 수 및 금연성공자 수 사업참여자대상집단심층면접및설문조사	▯ 연구활동 실적 및 성과결과물
중재사업 성과공유	▯ 지역보건기관과 주민이 참여하는 사업성과 결과보고회를 개최함	▯ 지역 보건소와 사업의 성과를 공유함(격차의 원인과전략을 도출해나가는 과정이 의미있었다고언급함	▯ 서울시 25개 자치구 금연사업 담당자 대상 세미나를 개최하여 사업성과를 공유함	▯ 성과와 확산필요성에 대한 평가를 위한 자문회의 계획
지속가능한 사업운영전략 제언	▯ 지역발전 로드맵에 (양평군 미래비젼 로드맵) 금연중재 전략 포함시킴 ▯ 지역내유관기관간네트워크형성및연계에대해 언급	▯ 지역사회 자원 연계, 이동금연클리닉, 혈관건강검진이 결합된 형태의 찾아가는 금연건강캠프 사업을 금연지원사업에 포함시켜 지속적으로 추진예정이며, 타 지역으로 확산예정임	▯ 지속가능한 사업운영을 위한 전략보다는 사업이 성공적으로 안착하기 위해 지역내 금연지원센터와 보건소가 연계되어야 하며 지역내 다양한 금연지원 서비스와의 전달체계를 확립해야 함을 제안하였음 ▯ 광역시도수준에서지역맞춤의지역금연상담전화의운영을고려해볼수있을것으로제안하였음	▯ 지속가능한 사업 운영을위해 보건소의 금연클리닉과 의료 기관의 금연지원센터 간 연계가능한 방법의 개발이 필요함을 제시하였음 ▯ 지역에서사업을적용하기위해서는 지역특색에 맞는 접근이 필요함을 제안하였음

<표 5> 종료사업 연차별 연구 상세 - 걷기실천율

구분	강원도의 영월군과 삼척시 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	경상남도의 의령군과 함안군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발
1차년도			
지표현황분석	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)
원인도출모델	□ CSDH	□ 다수준모델, 계획된 행동이론모형	□ CSDH, 건강믿음모형
사업/대조지역 비교	□ CHS 결과비교	□ CHS 결과비교 □ 건강프로파일 현황비교	□ CHS 결과비교 □ 건강프로파일
지역사회 가용자원과 역량 파악	□ 확인사항 없음	□ 건강증진사업 현황평가	□ 건강증진사업 현황평가
원인규명 활용자료	□ CHS □ 주민대상설문조사: 도보환경평가 및 걷기선호도 설문조사(사업지역과 대조지역 모두 실시) □ 지역물리환경적 자료분석: 보행교통실태조사 실시 (사업지역과 대조지역 모두실시)	□ CHS □ 주민대상설문조사: 걷기선호도 및 걷기환경조사 (사업지역과 대조지역 모두 실시) □ FGI등 질적연구: 지역내 요구도조사(지도그리기워크숍, FGI) □ 건강프로파일DB	□ '10~'19 CHS □ 주민대상설문조사: 걷기특성 및 환경조사(사업지역과 대조지역 모두 실시) □ 건강프로파일
지역추진위원회 구성 및 운영	□ 확인사항 없음	□ 확인사항 없음	□ 1차년도(7회), 2차년도(7회), 3차년도(5회) 추진

2차년도			
심층분석 활용자료	▯ 확인사항 없음	▯ FGI등 질적연구: 지역내 요구도조사(지도그리기 워크숍, FGI)	▯ 지역사회 걷기환경 및 요구도 심층조사(주민,기관,단체 설문조사) ▯ FGI등 질적연구: 지역주민 대표 및 유관기관 담당자
지역사회와 격차원인 정보공유	▯ 중재지역 선정을 위한 지자체와 지표검토회의	▯ 확인사항 없음	▯ 다회의 지역추진위원회 등을 통한 격차원인 정보고유
타 시군구 지표관련 보건사업 고찰	▯ 지표관련 보건사업 고찰: 충청남도 홍성군, 서천군의 유사사례제시	▯ 대조지역 건강증진사업의 양적,질적비교	▯ 양지역 전략별 건강증진사업 비교 및 평가
사회생태학적 모형 기반 전략도출	▯ 걷기활성화 노력방안을 포괄적으로 제시	▯ 확인사항 없음	▯ 가설모델에 따른 다방면 검증 및 전략도출
도출원인과 중재사업 간 연계성	▯ 영월군 한반도면의 도보환경 및 걷기공동체를 포함한 걷기환경인지 점수가 영월군전체와 삼척시에 비해 매우낮음(환경개선 및 걷기공동체 사업진행)	▯ 다양한 분석기법 활용하였으나 중재시범사업과의 연계성은 확인되지 않음 ▯ 도출원일을 통해 장단기계획을 제시(실제 수행하지는 않음)	▯ 걷기실천율 격차요인 도출 및 중재 추진모형을 통해 연계하고자 함
중재사업 내용	▯ 사업수행 결과제시(일시,장소,내용) ▯ 건강플러스 마을사업과의 연계추진(보건소 및 건강위원회조직이 이미 개설되어있음)	▯ 노인운동프로그램: 걷기지도자 중심(대상 및 내용에 대한 언급만 있음)	▯ 임실군걷기실천프로그램: 마을선정 및 마을단위 조직화, 지도자 선정, 걷기코스 개발 및 지도자양성 교육실시 등
중재사업 평가계획	▯ 환경평가 및 걷기선호도 전후조사 수행하지만 사전계획수립여부는 파악되지 않음	▯ 확인사항 없음	▯ 걷기실천환경, 실천력, 신체능력 등의 평가방법을 통해 걷기실천역량, 의식개선, 지식전달, 행동변화를 기준으로 11월 성과평가

3차년도			
중재사업 수행과정을 지역과 함께 모니터링	▯ 유관기관과의 회의를 통해 진행	▯ 확인사항 없음	▯ 걷기프로그램 동아리별 모니터링 진행
중재사업 평가	▯ 사업전후비교: 환경평가 및 걷기선호도 전후조사 수행하지만 사전사후 비교	▯ 사업전후비교: 운동능력 및 근육량 전후비교	▯ 사업전후비교: 설문조사 (걷기선호도, 걷기에 대한 인식), 건강상태(혈압 및 혈당, 지질검사, 동맥경화 및 유연성, 체성분분석)
중재사업 성과공유	▯ 강원건강포럼 성과보고회 개최	▯ 확인사항 없음	▯ 간담회 및 포럼을 통한 성과공유
지속가능한 사업운영전략 제언	▯ 지속성 있는 예산투입으로 꾸준한 지식의 확대와 걷기활동 리더양성이 필요함을 언급함 ▯ 지자체협력체계: 지역내 건강위원과 보건소의 지원체계를 활용한 중재지속에 대해 언급	장단기 계획 제안 ▯ 의령군내 신체활동 관련 사업을 많이 실시하는 것이 의령군 체육회(사업평가 및 모니터링방안교육필요) ▯ 보건소는 질병에 대한 관리차원의 신체활동 및 걷기실천사업진행	▯ 보건지소 공무원 업무부담해결, 건강증진사업 연계, 기존 커뮤니티 인적 인프라 활용 ▯ 걷기 자조모임, 주민 간 교류 및 유대감 형성, 걷기코스 개발 등

<표 6> 종료사업 연차별 연구 상세 - 이환

구분	광주광역시의 남구와 서구 간 당뇨병 관리 관련 지표 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	강원도의 인제군과 양구군 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	인천광역시의 옹진군과 부평구 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발
1차년도			
지표현황분석	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)	□ CHS지표 (지역사회건강조사)
원인도출모델	□ CSDH	□ CSDH	□ CSDH, 사회생태학적 모형
사업/대조지역 비교	□ 확인할 수 없음	□ CHS 결과	□ CHS 결과
지역사회 가용자원과 역량 파악	□ 관련 담당자(지역당 5명) FGI □ 당뇨병치료를 위해 의료기관 을 이용하는 환자심층조사	□ 확인사항 없음	□ 비만 관리사업 비교
원인규명 활용자료	□ FGI등 양적, 질적연구: 사업담당자 및 당뇨병환자 대상 심층조사 □ 건강보험공단자료	□ CHS □ FGI등 질적연구: 주민대상 심층면접조사 □ 국민경간보험공단자료	□ CHS □ FGI등 질적연구: 내부회의를 통해 선정한 기준에 따라 옹진군과 부평구 지역주민 그룹별 6~10명 □ 국민건강보험공단자료
지역추진위원회 구성 및 운영	□ 확인할 수 없음	□ 확인사항 없음	□ 확인할 수 없음

2차년도			
심층분석 활용자료	□ 확인할 수 없음	□ FGI등 질적연구: 주민대상 심층면접조사	□ CHS 결과분석: 도서지역을 포함한 전체지역비교
지역사회와 격차원인 정보공유	□ 확인할 수 없음	□ 확인사항 없음	□ 확인할 수 없음
타 시군구 지표관련 보건사업 고찰	□ 확인할 수 없음	□ 확인사항 없음	□ 확인할 수 없음
사회생태학적 모형 기반 전략도출	□ 확인할 수 없음	□ 이웃/읍면동단위(여성 여가활용 신체활동 프로그램 운영 필요성 제안)	□ 확인할 수 없음
도출원인과 중재사업 간 연계성	□ 환자와 의사 간 상호작용 요소가 필요하며, 이를 위한 환자의 역량강화 및 지표에 대한 이해도 제고 등을 위한 교육 진행	□ 대조지역에 비해 취약한 문제점을 규명하였고, 지역주민간 의견과 생각유사도가 높고 함께할 수 있는 프로그램에 대한 선호가 높아 규범의 영향이 클 것. □ 비만인식개선 및 건강행동 변화촉진을 위한 사회적 마케팅 □ 역량강화 및 지역내확산을 위한 커뮤니티 활성화	□ 비만의 주요원인을 개인을 둘러싸고 있는 환경과 사회문화적 요인 등으로 파악하고 있으며, 이에따라 지역사회기반의 비만관리사업 일환으로 리더교육 및 주민참여 프로그램 추진계획
중재사업 내용	□ 자가관리 역량을 강화할 수 있는 집단보건교육과 상담	□ 사업대상 및 내용 : 남면 중년 여성 대상 건강지킴이	□ 비만격차 해소운동프로그램 (4주과정)
중재사업 평가계획	□ 자가관리 역량강화 프로그램 효과평가	□ 사업의 구조, 과정, 결과평가 계획수립	□ 확인할 수 없음

3차년도			
중재사업 수행과정을 지역과 함께 모니터링	▯ 중재사업 이후 전화상담을 통한 프로그램 참여도 모니터링	▯ 보건소 및 행정복지센터와의 협조체계를 구축	▯ 리더교육 및 비만격차해소 프로그램 구성 및 추진
중재사업 평가	▯ 사업전후비교: 당화혈색소, PHQ-9, 당뇨병 자기관리 지식, 만성질환 관리평가 비교	▯ 사업전후비교 : 건강지킴이 사전사후 효과평가 ▯ 중재사업만족도:교육프로그램만족도,난이도평가 ▯ 기타:RE-AIM모형기반사회적마케팅효과분석	▯ 사업전후비교: 건강행태 비교
중재사업 성과공유	▯ 워크샵을 통한 성과공유	▯ 확인사항 없음	▯ 확인할 수 없음
지속가능한 사업운영전략 제언	▯ 당뇨병 관리능력 향상을 위한 접근방법(일차의료를 계획과 평가기반), 당뇨병 관리사업 참여율 증가, 기관의 역할	▯ 지자체 협력체계: 지속가능한 사업을 위해 지역사회 유관기관과 협력관계 중심으로 수행함 ▯ 모니터링방안:건강지킴이 확산을 위한 제도적개선 및 모니터링과평가 필요함을언급 ▯ 사업확산 및 지속을 위한 수정된 중재방안: 건강지킴이 확산을 위한 제도적개선 및 모니터링과평가 필요함을언급 ▯ 기존사업과의연계전략: 농촌 지역에서의 지역소식지 활용	▯ 중장기 사업 추진 로드맵 수립 ▯ 비대면과 위탁운영 방식확대, 지역심층조사, 지역사회 자원활용

<표 7> 종료사업 연차별 연구 상세 - 그 외

구분	부산광역시의 동구·중구·서구·영도구와 남구 간 고위험음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	충청남도의 금산군과 공주시 간 고위험음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	대구광역시의 남구와 동구 간 중등도 이상 신체활동실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발	부산광역시의 수영구와 해운대 간 암검진율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발
1차년도				
지표현황분석	▯ CHS지표 (지역사회건강조사)	▯ CHS지표 (지역사회건강조사)	▯ CHS지표 (지역사회건강조사)	▯ CHS지표 (지역사회건강조사)
원인도출모델	▯ CSDH, 사회생태학적모형, WHO 해로운 음주감소를 위한 세계전략(WHO전략)	▯ 공중보건학적 모델, CSDH	▯ CSDH	▯ 건강신념모델, 의료이용행태모형, 계획된 행동이론, 단계별 행위변화모형, PRECEDE-PROCEED 모형
사업/대조지역 비교	▯ CHS 결과비교 ▯ 인구/소득수준음주 관련환경(읍면동별음식점/주점분포, 음주운전단속건수) ▯ 자자체절주사업(WHO전략항목)비교	▯ CHS 결과비교 ▯ 주거환경및사회경제적환경	▯ CHS 결과비교 ▯ 인구, SES현황 ▯ 기타: 건강프로파일 자료분석	▯ 개인단위 영향요인, 박탈요인
지역사회 가용자원과 역량 파악	▯ WHO전략에 따른 절주사업 현황(예산, 인력, 사업) 파악	▯ WHO전략에 따른 절주사업 현황(예산, 인력, 사업) 파악	▯ CHS ▯ 주민대상설문조사 ▯ 지역물리환경적자료분석 ▯ 국민건강보험공단자료, 건강프로파일 DB	▯ 검진기관 관련 파악
원인규명 활용자료	▯ '15-'17 CHS 원시자료분석, 읍면동별 분석 ▯ 지역사회네트워크및기업/단체/공공기관음주문화조사	▯ '10-'16 CHS 원시자료분석 ▯ '12,'14,'16사회통계자료통합분석(술로스트레스해소한다는문항활용) ▯ 건강프로파일DB ▯ 보건소및마을건강센터담당자의견조사 ▯ 음주문화및음주행태설문조사	▯ CHS, FGI, 국민건강보험공단	▯ CHS ▯ 국민건강보험공단 암검진통계
지역추진위원회 구성 및 운영	▯ 확인사항 없음	▯ (2차년도-월1회)	▯ 확인사항 없음	▯ 확인사항 없음

2차년도				
심층분석 활용자료	▯ FGI(고위험음주 집단 인터뷰) ▯ 기업/단체/공공기관 음주문화 조사자료 심층분석	▯ 절주 어플리케이션을 통한 심층원인분석 ▯ FGI ▯ 고위험음주율높은지역환경요인파악을 위한현장점검(포토보이스기법활용(SHOWeD))	▯ 주민대상 설문조사: 남구, 동구 주민 각 600명 대상 전화 및 대면 설문조사 ▯ FGI등 질적연구: 주민자치위원 및 사업참여기관 담당자대상 FGI ▯ 대명6동 마을현황 분석을 위한 리빙랩	▯ FGI등 질적연구: 목적적 표본추출(20명)
지역사회와 격차원인 정보공유	▯ 건강생활실천협의회: 결과발표	▯ 유관기관과 업무협의회 진행함	▯ 주민조직화 워크숍 (주민자치회기반 지역사회현황파악 및 사업기획)	▯ 확인사항 없음
타 시군구 지표관련 보건사업 고찰	▯ 대조지역과 절주사업비교	▯ 5개 구의 절주사업 비교	▯ 대조지역과 신체활동사업비교	▯ 확인사항 없음
사회생태학적 모형 기반 전략도출	▯ 사회생태학적 모형에 기반한 전략 도출함	▯ 1차예방/2차예방/3차예방에 기반하여 전략도출	▯ 이웃/읍면동단위(지역기반접근/주민참여형사업전략 도출)	▯ 개인/지역단위분석을 통한 전략도출
도출원인과 중재사업 간 연계성	▯ 지역적특성(산업비중),주민특성(높은 모임 빈도, 술의 애호도와 의존도가 높음)에 맞추어 조례개정 및 절주지킴이, 서포터즈 양성	▯ 동구의 2개동,남구의 1개동을 선정하여 격차원인도출(사회적 결정요인과 사회자본 의격차 / 지역환경과 건강에 대한 관심 및 실천의차이 / 음주접근성 높고 허용적인 태도의 차이---)환경에 대한 변화와 함께 교육중재, 주민교육 및 역량교육)	▯ 동구에 비해 환경적으로도 취약하고 신체활동사업에 있어서도 주민참여도가 낮음을 파악함에 따라 사업기획단계에서부터 주민이 주도하여 진행하도록 함	▯ 암검진율 영향요인 및 향상방안을 마련하고 관련 중재방안으로 '함께 검진과정 준비하기', '함께 건강해지기' 등 마련
중재사업 내용	▯ 기획과정은 명시되어있지 않고 결과만 제시됨(1,2의 내용정도만 기재됨)	▯ 육하원칙에 따른 내용제시	▯ 사업대상 및 내용: 대명6동 주민대상 주민자치회구성 및 운영(건강리더 양성 교육 및 등산 걷기 등 주민 주도적 사업기획 및 참여) ▯ 사업수행조직:주민자치회구성 ▯ 지역내가용자원:주민건강리더활용 ▯ 기존사업과의연계 ▯ 지역사회참여전략:주민자치회구성및 운영	▯ 함께 검진과정 준비하기, 예약하기, 문진표 사전안내 등 ▯ 검진 결과 통보 후 상담/건강활동 안내 ▯ 마을건강동아리 등을 통한 독려활동(함께 건강해지기)
중재사업 평가계획	▯ AUDIT_k, 인식 및 지식의 사전사후 검사를 통한 평가는 진행되었으나 사전 계획수립여부는 파악되지 않음	▯ 인식도 전후조사 수행에 대한 사전계획수립여부 파악되지 않음	▯ 확인사항 없음	▯ 확인사항 없음

3차년도				
중재사업 수행과정을 지역과 함께 모니터링	▯ 확인사항 없음	▯ 유관기관과의 회의: 12회	▯ 확인사항 없음	▯ 확인사항 없음
중재사업 평가	▯ 사업전-후 비교(AUDIT_k, 인식 및 지식)	▯ 고위험음주단기개입사업효과를 위해 AUDIT평가 ▯ 사업전후인식조사	▯ 지역 중재사업 수행 가능성: 질적평가를 통해 주민건강조직으로서 주민자치회의 가능성 확인	▯ 확인사항 없음
중재사업 성과공유	▯ 건강생활실천협의회: 결과발표	▯ 지역 내 결과공유는 되지 않은것으로 파악	▯ 확인사항 없음	▯ 확인사항 없음
지속가능한 사업운영전략 제언	▯ 고위험음주율 사업 로직모델(투입-활동-산출-결과)을 참고하여 보건소 내 사업 지속 및 모니터링을 제시 (보건소 및 타기관 연계,주민참여,보건소담당자역량강화 및 자영업자 설득을 위한 행정적지원 방안필요 언급	▯ 보건소 내 전담인력 투입, 유관기관 및 기존사업과의 연계, 장단기적 모니터링 지표제시	지자체협력체계 ▯ 주민자치회중심의 주민참여형보건사업의 전략제시 ▯ 보건소와 행정복지센터가 연계하고 보건관련 전문가와 마을활동전문가가 지원하는 모형제시	▯ 건강지킴이 암예방검진 역량강화 프로그램개발을 통한 효과를 정량,정성적 확인하는 후속연구 제언

나. 종결사업 대상 연구책임자 심화인터뷰 추진 결과

○ 종결사업 연구책임자 심화인터뷰 추진 개요

- (목적) 지역 간 건강격차 해소 종결사업 대상 우수사례 발굴 및 성과확산을 위한 사업 연구책임자 대상 심화인터뷰 실시
- (기간) 2023년 09월 13일(수) ~ 09월 20일(수)
- (진행방식) 화상회의
- (대상자) 2회 이상 사업 참여 연구책임자(2인) 및 ’22년 종료사업 연구책임자(3인)

<표 8> 심화인터뷰 대상자 목록

일시	성명(소속)	과제명	비고
9월13일(수) 10:00	김창훈 (부산대)	부산광역시의 수영구와 해운대 간 암검진율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(’20-’22)	-
9월14일(목) 13:30	문종윤 (가천대)	인천광역시의 옹진군과 부평구 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘20-’22)	-
9월14일(목) 15:00	이효영 (동서대)	부산광역시의 동구·중구·서구·영도구와 남구 간 고위험 음주율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘18-’20)	2회 이상 참여
9월15일(금) 14:00	이영훈 (원광대)	전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘20-’22)	2회 이상 참여
9월20일(수) 10:00	오경재 (원광대)	전라북도의 김제시와 정읍시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발(‘18-’20)	2회 이상 참여

참고	심화인터뷰 진행 순서 및 주요 질의 내용

1. 추진 사업에 대한 연구 배경 및 과정, 결과 등 사업 전반에 대한 전반적인 소개

2. 지역사회 건강격차 해소사업을 통해 도출한 중재모델 활용 방안

○ 격차 원인 도출 및 결과 검증의 과정

○ 중재모델 적용 후 효과

- 해당지표의 격차 감소, 주민 인식개선 등

○ 타 지역 적용을 통한 사업 확산 가능성 유무

○ 지자체 안착 및 사업 지속여부

- 사업 관련 기술지원 요청 사례 유무

○ 사업 우수사례 발굴을 위한 평가기준 제안

○ 사업 참여 경험 및 성과 공유를 위한 확산·홍보 방안 등

3. 지역사회 건강격차 해소사업 추진시 애로사항

○ 지자체 참여도 정도, 주민인식, 기타 예측하지 못한 어려움 등

4. 지역사회 건강격차 해소사업 추진을 위한 기술지원체계 구축 관련

○ **연구자간** 네트워크 구축 및 운영에 대한 필요성

○ **연구자-지자체 간** 네트워크 구축 및 운영에 대한 필요성

- 과제 종결 후 지자체에서 연속으로 자체 사업수행 시 기술지원
- 과제 경험이 없는 타 지역에서의 자체 사업수행 시 기술지원

5. 지역사회 건강격차 해소사업관련 개선 사항

○ 종결사업 연구책임자 심화인터뷰 종합

- 지역별 건강격차 요인이 다양하게 연결되어 있어 원인규명에 맞춘 중재모델 제시에 어려움 존재하였음

  、 특히 사업 기간중 코로나19로 인해 중재사업 수행에 어려움이 있었음

- 지자체가 보유하고 있는 자원 정도에 따라 중재사업의 효과정도가 상이하였으며 지역 내 조직(플랫폼)을 활용하거나 기존 자원들을 연계하여 운영하는 등 통합적 접근 관점 필요함

  ※ 부산의 경우 마을건강센터를 적극적으로 활용하여 중재사업을 운영하였음

- 사업 지표 격차 해소를 위해 관련 정책 및 제도 등이 강제되고 지속적인 예산투입이 이뤄져야 유지가 가능할 것으로 판단됨

  ※ 보건인력의 인사이동 등의 사유로 중재사업 지속에 어려움 존재

- 중재사업에 참여하는 군민들의 의지를 비롯하여 이해관계자의 수용성과 지자체의 협력 정도가 중재사업에 영향을 미침

► [붙임] 인터뷰 결과(5인)

(1) 230913	부산대 김창훈 교수
연구명	부산광역시 수영구와 해운대 간 암검진율 격차

인터뷰결과

가. 사업 추진 과정 및 연구 결과

○ 부산 수영구와 해운대의 생활수준이 비슷하여 비교지역으로 선정됨

- 부산시가 주도하여 진행하여 선정된 사업임

○ 지역사회건강조사 데이터와 건강보험공단의 암 필수 검진율 자료 등을 확보하여 분석 실시

- 지역사회건강조사 데이터의 한계(신뢰성 등)가 존재함으로 관련 유사지표를 비교하는 것을 제안

○ 코로나19로 인한 활동 축소, 비대면으로 축소하여 진행

나. 우수사례

○ 건강격차 원인규명을 위하여 두 지역간 동단위(세부지역)의 지역사회건강조사 자료 비교·분석을 통해 암건진율 차이를 확인

다. 사업 개선 방안

○ 중재사업은 지자체와의 소통 중요하지만 지자체와 국회의원의 관심을 갖기 어려운 분야임

○ 중재사업을 위해서는 지역내 조직(플랫폼 등)들을 포함해서 이행되어야 함

- 마을건강센터 등 플랫폼을 구축하여 운영한다면 사업이 효과적으로 운영될 것으로 기대
  - 、 부산지역내 마을건강센터는 마을밀착형 보건의료 활동을 실시
  - 、 부산지역내 70개소가 운영중에 있으며 인건비만 연간 1억 원 소요됨

○ 정책과 제도를 강제하지 않다면 사업이 성공적으로 이뤄지기 어려움

○ 성공적인 중재사업을 위해 국민건강증진계획에 '격차해소' 목표를 명시(공표)하고 전략이 마련되어야 함

라. 기타

○ 부산에는 건강지원센터 수가 적어 마을건강센터(70개소)를 설치하여 운영중

- 실행 조직은 보건소임

○ 건강형평성학회 운영중(10주년)

- 2023년부터 저널 발간
- 보건학, 예방의학 관련 연구자

○ 연구자 연구분야

- 사회역학 주 전공으로 현재 공공의료 정책*을 주로 연구하고 있음

* 암 발생 역학, 감염병 역학(결핵), 심혈관 등

(2) 230914	가천대 문종윤 교수
연구명	인천광역시 옹진군과 부평구 간 비만율 격차

인터뷰결과

가. 사업 추진 과정 및 연구 결과

○ 도서지역으로 인한 사업 추진 한계 발생

- 사업지역이 도서지역(섬)으로 보건지소가 운영중이지만 공공의만 있어 직접적인 사업수행인력 부재

※ 인천광역시내 보건소 위치하여 참여 연구진이 도서지역을 이동하여 사업을 운영하였음

- 중재사업의 경우, 통합건강증진사업이 제시한 프로그램을 적용하고자 하였지만 운영에 어려움이 있어 1회성 프로그램으로 단축하여 운영

※ 교통 이용이 어려워 연구자가 프로그램을 운영·관리하기에 한계가 있었음

- 지역내 제철 과일 및 채소 등의 수급이 어려워 식이프로그램 적용에 한계 존재

○ 관계자 및 지자체(보건소)가 건강격차 해소사업에 대한 이해 부족으로 전반적인 사업 진행에 어려움이 있었음

※ 지자체에서는 3차 년도부터 관심을 가졌으며, 옹진군민 전체를 대상으로 한 사업을 희망

나. 우수사례

○ 지역건강사회조사 자료의 연령을 세분화하여 비만율 원인 격차 비교·분석을 시행

※ (예) 65세 이상 등 연령대 세분화

○ 중재사업의 경우 지식 전달의 목적보다는 메시지를 전달하는 데 중점을 둠

다. 사업 개선 방안

○ 건강격차 해소사업은 개인맞춤형으로 중재사업이 제시되어야 함

라. 기타

○ 연구책임자 변경으로 인해 2차 년도부터 사업 참여

○ 연구자 연구분야

- 보건의료정책이 주 전공으로, 역학, 환경 분야를 비롯한 건강증진사업을 주로 연구하고 있음

(3) 230914	동서대 이효영 교수
연구명	부산광역시 동구·중구·서구·영도구와 남구 간 고위험 음주율 격차

인터뷰결과

가. 사업 추진 과정 및 연구 결과

○ 사회자본과 인구사회학적 변수가 주요 원인으로 확인

- 부산 동구·중구·서구·영도구의 고위험 음주율의 주요 요인이 다르게 확인됨
- 부산 동구의 경우 소득 최하위 수준으로 부두 노동자가 주로 거주하며, 술 문화에 관대한 특징이 있음
- 지역에 따라 인프라, 재정적(예산 가용범위) 차이가 존재

○ 원인규명에 1~2년 소요, 중재모델 도출 및 적용에 8개월 기간 소요

○ 알콜중독의 경우 지역 중독센터 또는 사회복지시설에 연계

※ SBIRT(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment)을 적용

○ 코로나19로 인한 활동 축소

나. 우수사례

○ 사업과 관련된 이해관계자 및 지자체의 관심과 참여도를 높임

- 부산지역내 마을건강센터(동사무소내 위치)를 활용하여 고위험 음주율 감소에 노력

※ (협력) 마을건강센터내 간호사, 마을활동가, 동장 2인, 사회복지파트 과장, 청년회 등 참여

○ 사업의 연구책임자가 지자체, 보건소 등에 찾아가 적극적으로 사업 참여를 유도하고자 노력

- 연구책임자는 부산금연지원센터에서 찾아가는 서비스사업을 관리하고 있으며, 중재사업과 연계하여 사업을 수행하였음

다. 사업 개선 방안

○ 권역별 질병대응센터의 역할 강화

- 권역별 질병대응센터가 함께 참여함으로써 보건소가 적극적으로 사업에 관심을 가지고 참여할 수 있도록 센터의 촉진 역할 필요
- 질병대응센터와 지자체가 지역협의체의 중심이 되어 운영될 수 있도록 조정 필요

※ 지역협의체(1년에 4회 모임)를 위해 관계기관(질병청-대응센터-지자체/보건소)이 한 번에 모이기 어려운 부분이 있어 일정 조율이 잘 되지 않는 부분이 있음. 지자체와 질병대응센터가 중심이 되어 효율적으로 운영될 수 있도록 제도 개선 필요

라. 기타

❍ 지역사회건강조사 데이터 관련하여 지표별 특성에 따라 경향 차이가 존재하며 안전성 문제 존재

※ 걷기실천율의 경우 도시와 농촌지역간의 데이터 특성 차이를 보임

❍ 현재 부산 북구(사업지역)와 수영구(대조지역)에 걷기실천율 과제를 수행중으로 사업의 지속성을 위해 걷기활성화 관련 조례 제정을 준비중임

- 비용 지원 근거를 마련함으로써 예산지원의 당위성을 확보하기 위함

❍ Track your Accepted article 자료 공유

❍ 연구자 연구분야

- 보건학 주 전공으로 지역사회 보건분야를 주로 연구하고 있음

※ 간호학 학사, 보건학 석박사 학위

(4) 230915	원광대 이영훈 교수
연구명	전라북도 임실군과 고창군 간 걷기실천율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발

인터뷰결과

가. 사업 추진 과정 및 연구 결과

○ 지역사회건강조사 데이터의 전반적이 추이 확인 필요(단년도 비교)

- 5년치 데이터에 대한 통합 분석 실시

○ 코로나19로 인한 활동 축소

나. 우수사례

○ 지역의 특성을 고려한 원인 규명 분석 실시

- 임실군의 경우 사회활동참여율과 공원의 접근성이 낮음을 확인
- 고창의 경우 작은 공원이 촘촘히 조성되어 있으며 걷기실천을 위한 캠페인 실시

○ 지자체(보건소)가 자발적으로 사업을 지속 운영할 수 있도록 유도

다. 사업 개선 방안

○ 사업의 지속성을 위해 6개월 사업운영 이후에 보건소가 자율적으로 운영할 수 있도록 유도하는 방안을 제안

- 중간관리자로써 보건지소 참여할 수 있도록 함

○ 걷기실천율 격차 해소를 위해 지역의 문화로 자리매김할 수 있도록 해야 함

- 인식개선 및 동기부여를 할 수 있는 중재사업 개발 필요

○ 건강격차 해소를 위해서는 지역주민에 대한 다수준, 다차원의 전략 필요

○ 국민건강증진계획에 목표치를 제시해서 체계적인 감시와 관리감독이 가능하도록 해야 함

- 지역사회의 충분한 의지(의무와 책임감)와 예산 투입 필요

라. 기타

○ 원광대 오경재 교수와 함께 4개의 건강격차 해소사업을 수행한 경험이 있으며 현재 익산-군산 간의 고혈압 과제를 수행중

(5) 230920	원광대 오경재 교수
연구명	전라북도 김제시와 정읍시 간 현재흡연자의 금연시도율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발

인터뷰결과

가. 사업 추진 과정 및 연구 결과

○ 흡연 문화, 정책적 및 개인적 특성 등 어떤 점이 문제(요인)인지 파악하고자 하였음

- 인구적, 환경, 경제적, 지리적 특성은 지역 간 비슷한 경향을 보임
- 전라북도의 경우 낙후지역으로 (대학)교수자원이 부족하며, 보건소는 경제적으로 어려움에 있으며 정책 우선순위에서 후순위에 위치

○ 김제시의 경우 금연시도율에 대한 인식(동기부여)는 낮았지만 금연 프로그램을 운영하고 있었고, 정읍시의 경우 금연 프로그램은 없었지만 금연에 대한 인식은 높았음을 확인

- 금연시도율에 대한 홍보가 중요함을 확인

○ 코로나19로 인한 활동 축소

나. 우수사례

○ 지자체(전라북도)의 사업 의지가 높았으며, 기존 통합증진사업과 연계하여 진행

○ 보건소내 부서별 연결 및 유관기관 연계를 통해 사업을 추진

- 금연사업팀, 심혈관질환팀, 만성질환팀 통합적으로 연계하여 프로그램 개설
- 중재사업 대상자의 접근성을 보완하고자 노력

※ (중재사업) 찾아가는 건강캠프 실시

다. 사업 개선 방안

○ 지자체의 의지와 보건소의 역량 및 예산이 중요함

- 특히, 보건소의 사업 담당자의 의지 및 역량 중요

※ 담당자는 6개월 ~ 1년 단위로 교체되기 때문에 역량 유지는 중요한 이슈이며, 보건소 담당자가 사업에 필요성, 소명, 가치 등을 공유할 수 있도록 해야 함

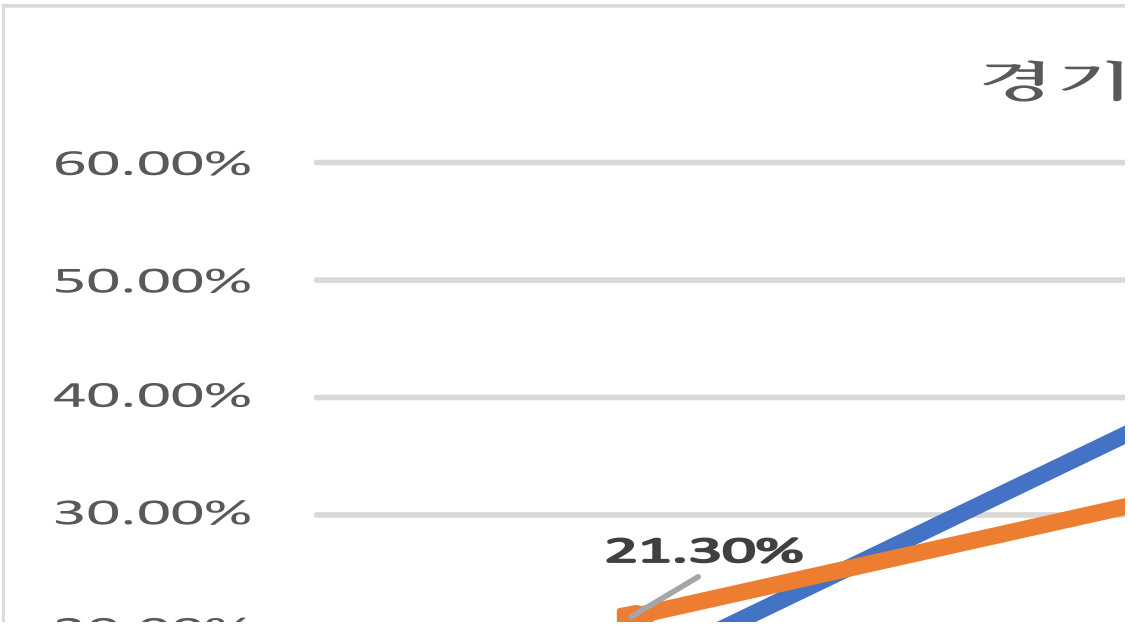
- 대학은 기술자문의 역할을 담당

○ 중재사업의 효과는 장기적인 관점에서 5~10년 정도 이후 확인할 수 있을 것으로 예상

다. 종결사업 성과분석

○ 현재흡연자의 금연시도율에 따른 중재전략 검토 결과

- 경기 양평군과 광주시('17-'19년)
  - 、 대부분 보건영역의 교육(캠페인, 정보) 중재에 분포되어 있었으며 개인, 학교/조직, 이웃/읍면동, 시군구 전체 단위 수준에서 고르게 중재 시행
  - 、 사업 이후 금연시도율 격차감소 및 역으로 격차가 발생하여 중재사업의 성과를 확인



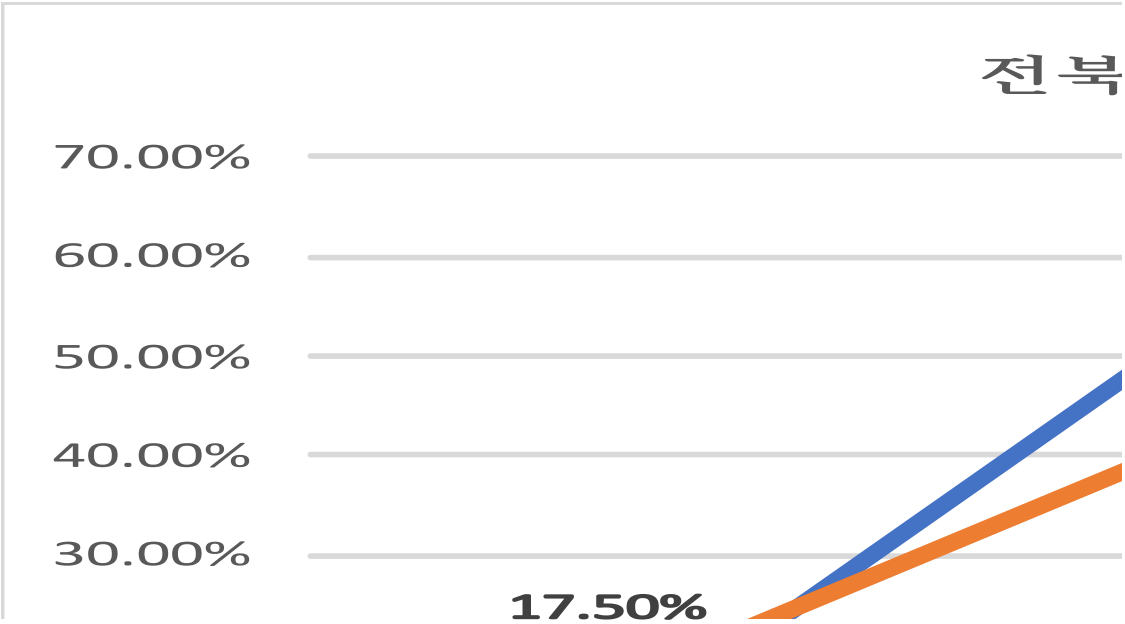
[그림 1] 경기 양평군-광주시 현재흡연자의 금연시도율

<표 9> 경기 양평군-광주시 현재흡연자의 금연시도율

금연시도율	2018년	2019년*	2020년	2021년	2022년
경기 양평군	16.3%	42.1%	46.8%	36.2%	56.3%
경기 광주시	21.3%	33.2%	25.2%	25.2%	17.1%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 전북 김제시와 정읍시('18-'20년)
  - 보건영역 및 사회환경영역 등 고르게 분포되어 있었으며, 보건영역에서는 개인단위와 이웃/읍면동 단위에서 사회환경 영역에서는 개인 간, 학교/조직, 시군구전체에 고르게 중재 시행
  - 중재사업을 실시한 3차년도 사업지역의 지표가 역전하는 현상이 있었으나, 사업 이후년도 다시 격차가 발생함 그러나, 사업 전후 사업지역의 금연시도율의 크게 증가하였으므로, 중재사업의 성과가 있었다고 볼 수 있음



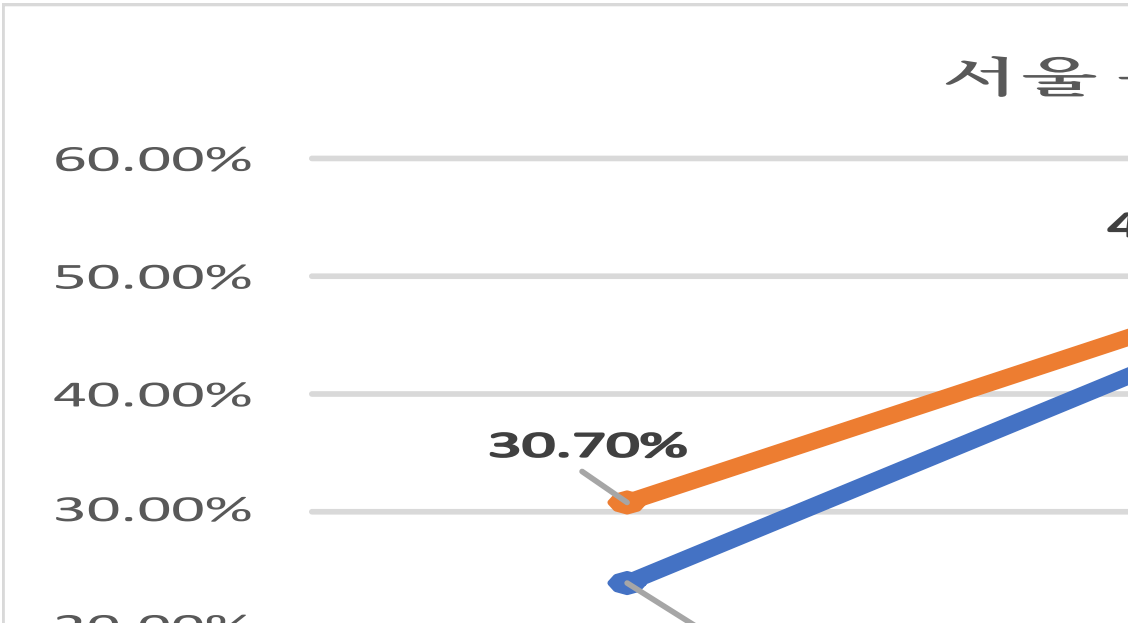
[그림 2] 전북 김제시-정읍시 현재흡연자의 금연시도율

<표 10> 전북 김제시-정읍시 현재흡연자의 금연시도율

금연시도율	2018년	2019년	2020년*	2021년	2022년
전북 김제시	12.7%	56.7%	58.0%	32.3%	34.9%
전북 정읍시	17.5%	44.0%	41.2%	50.7%	30.5%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 서울 동대문구과 광진구('19-'21년)
  - 보건영역의 교육, 전달방식의 변화와 사회문화적 환경의 중재가 시행되었으며, 단위별로 개인, 개인간, 학교/조직 단위에서 중재가 시행되었음
  - 사업 전후 사업지역의 금연시도율이 증가하였으나, 오히려 격차가 커져, 중재사업의 성과가 미미함



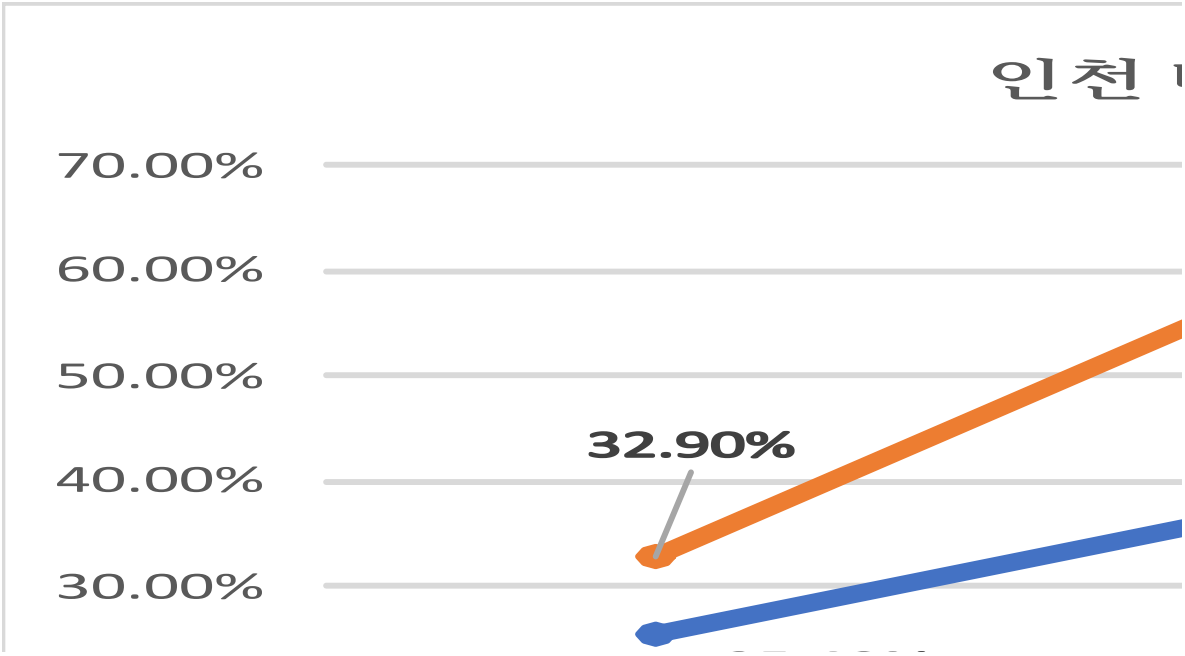
[그림 3] 서울 동대문구-광진구 현재흡연자의 금연시도율

<표 11> 서울 동대문구-광진구 현재흡연자의 금연시도율

금연시도율	2018년	2019년	2020년	2021년*	2022년
서울 동대문구	23.9%	46.2%	47.0%	36.9%	39.5%
서울 광진구	30.7%	48.4%	46.1%	46.6%	50.6%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 인천 미추홀구와 연수구('19-'21년)
  - 보건영역의 교육과 전달방식의 변화 측면의 중재가 시행되었으며, 단위별로 고르게 중재가 시행되었음
  - 사업 전후 사업지역의 현재흡연율이 소폭 감소하였으나, 격차의 변화가 없어 중재사업의 성과가 미미함



[그림 4] 인천 미추홀구-연수구 현재흡연자의 금연시도율

<표 12> 인천 미추홀구-연수구 현재흡연자의 금연시도율

금연시도율	2018년	2019년	2020년	2021년*	2022년
인천 미추홀구	25.4%	38.1%	37.1%	42.3%	31.5%
인천 연수구	32.9%	59.8%	53.3%	41.6%	51.1%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

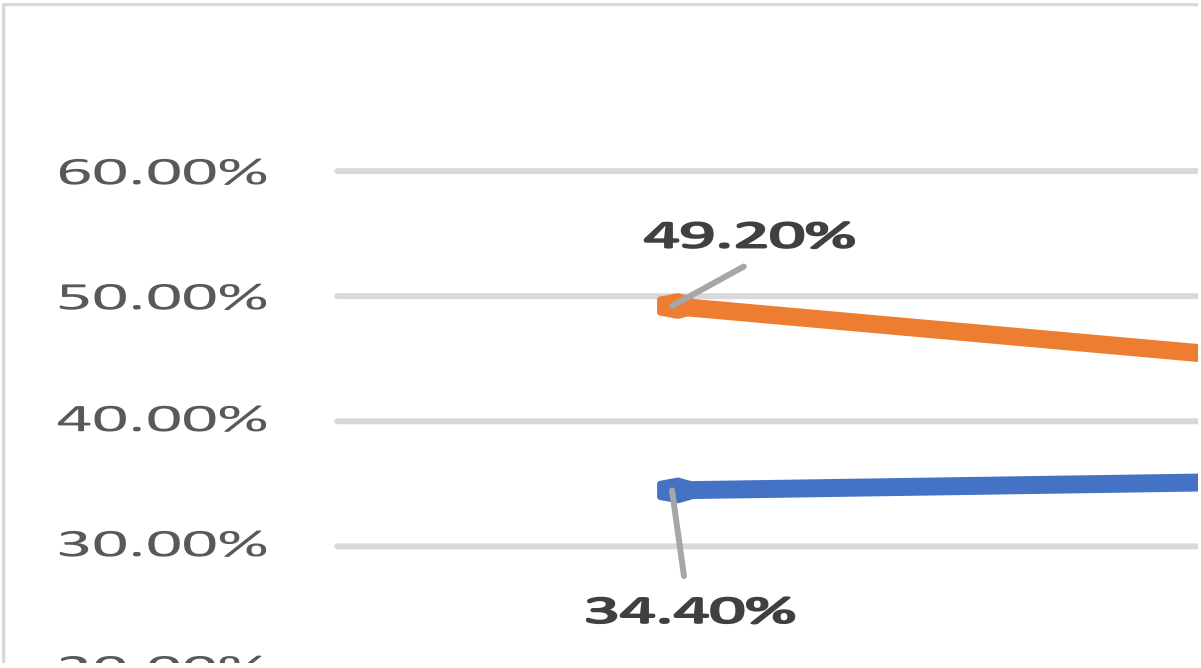
<표 13> 현재흡연자의 금연시도율에 따른 중재전략 비교

지역	경기도의 양평군과 광주	전북 김제시와 정읍시	서울 동대문구와 광진구	인천 미추홀구와 연수구
개인	○ 보건영역(교육) - 군 내 금연유도 홍보안내판 설치 - 주민참여 설명회 개최	○ 보건영역(교육) - 금연 건강캠프 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 금연 건강캠프 ○ 보건영역(전달방식의 변화) - 금연 건강캠프 - 약국에서 개인에게 금연상담 및 권고	○ 보건영역(교육) - 자녀(유치원, 어린이집)대상 금연교육을 통해 가정 내 금연환경 조성 - 건강검진 수검자 대상 - 전통시장 상인 대상 ○ 보건영역(전달방식의 변화) - 건강검진 수검자 대상 금연클리닉으로 연계사업	○ 보건영역(전달방식의 변화) - 금연앱 개발
개인간		○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 금연지지자 발굴 및 금연권고 분위기 조성	○ 보건영역(교육) - 아파트 내 가족대상 금연부스 운영 ○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 자녀(유치원, 어린이집)가 부모에게 금연권고 및 금연지지	
학교/직장(조직/기관)	○ 보건영역(교육) - 건강한 직장만들기 사업 - 전통시장내 상인대상 금연교육 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 건강한 직장만들기 사업	○ 사회환경영역(정치적 환경_규제) - 조직, 기관, 단체의 금연규칙 제정	○ 보건영역(전달방식의 변화) - 전통시장 내 상인대상 이동금연클리닉 운영 ○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 상인 간 상호 금연지지	○ 보건영역(교육) - 대학교 대상 담배없는 캠퍼스 홍보캠페인 진행 ○ 보건영역(전달방식의 변화) - 금연클리닉 운영 고도화 사업
이웃/읍면동	○ 보건영역(교육) - 지역 내 건강골든벨 행사 개최 ○ 보건영역(전달방식 변화) - 동네주민 참여 건강실천모임 조직과	○ 보건영역(전달방식의 변화) - 지역주민대상 찾아가는 이동 금연클리닉 제공 - 주민참여 건강실천		○ 보건영역(교육) - 아파트 입주민 대상 금연아파트 제도 홍보

지역	경기도의 양평군과 광주	전북 김제시와 정읍시	서울 동대문구와 광진구	인천 미추홀구와 연수구
	운영 - 군 주민대상 찾아가는 이동 금연클리닉 제공	모임 조직과 운영 - 마을 건강지도자 양성 및 역량강화		
시군구 전체	○ 사회환경영역(정치적 환경_규제) - 금연추진을 위한 주민운영위원회 구성 - 역 주변 금연광장 조성	○ 사회환경영역(정치적 환경_규제) - 금연추진을 위한 주민운영위원회 구성		○ 보건영역(전달방식의 변화) - 국가 금연상담전화 연계지역 금연 상담전화 시범운영
효과 평가 방법	○ 단년도 사업진행만으로 결과지표를 평가하기에 제한이 있음 ○ 향후 계속적으로 모니터링 할 수 있는 흡연 관련 지표제안	○ 중재사업 참여자 대상 단면조사 (금연건강캠프 및 금연클리닉 참가자 대상)	○ 중재사업 참여기관 대상 FGI ○ 전문가 대상 사업내용 평가 세미나 ○ 중재사업 참여자 대상 단면조사	○ 중재사업 참여자대상 단면조사

❍ 걷기실천율에 따른 중재전략 검토 결과

- 강원 영월군과 삼척시('17-'19년)
  - 보건영역 및 이웃/읍면동 중심의 중재전략 시행
  - 사업 전후 사업지역의 걷기실천율이 소폭 증가하였으며, 사업 후 사업지역의 지표가 더 좋아짐. 그러나 이는 대조지역의 지표가 대폭 감소하여 나타난 현상이므로 중재사업의 성과가 유의미하였다고 할 수 없음



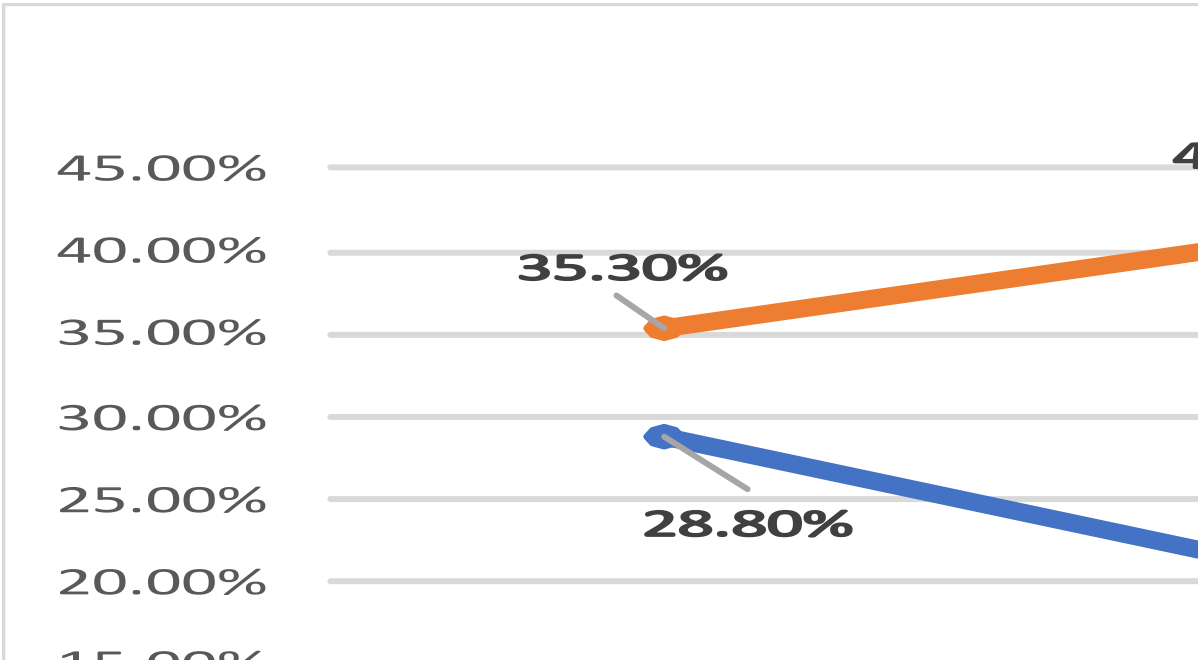
[그림 5] 강원 영월군-삼척시 걷기실천율

<표 14> 강원 영월군-삼척시 걷기실천율

걷기실천율	2018년	2019년*	2020년	2021년	2022년
강원 영월군	34.4%	35.1%	37.2%	25.8%	38.7%
강원 삼척시	49.2%	44.6%	29.6%	32.3%	31.2%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 경남 의령군과 함안군('18-'20년)
  - 보건영역 및 개인, 이웃/읍면동 중심의 중재전략 시행
  - 사업 전후 사업지역의 걷기실천율이 소폭 증가하였으나, 사업 후 대조지역과의 격차가 더 크게 나타나 중재사업의 성과는 미미함



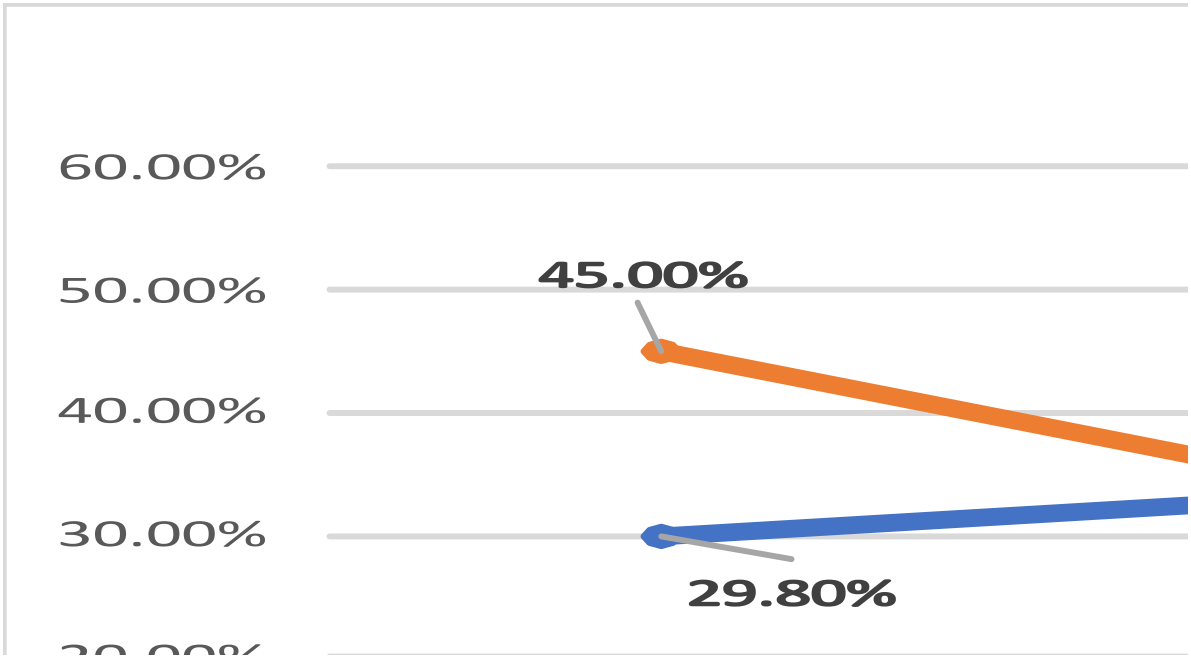
[그림 6] 경남 의령군-함암군 걷기실천율

<표 15> 경남 의령군-함암군 걷기실천율

걷기실천율	2018년	2019년	2020년*	2021년	2022년
경남 의령군	28.8%	20.2%	25.9%	29.9%	32.0%
경남 함안군	35.3%	41.2%	36.9%	35.9%	39.9%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 전북 임실군과 고창군('20-'22년)
  - 이웃/읍면동 단위 중심의 중재전략 시행
  - '22년 종료사업이므로 사업 후 지표확인이 불가능하였으나, 3차 년도까지의 지표의 증가추세가 매우 크게 나타났으며, 대조지역의 지표 또한 증가추세였으나 사업지역의 지표가 더 좋아졌으므로, 중재사업의 성과가 있었다고 할 수 있음



[그림 7] 전북 임실군-고창군 걷기실천율

<표 16> 전북 임실군-고창군 걷기실천율

걷기실천율	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년*
전북 임실군	29.8%	33.0%	22.8%	33.8%	50.3%
전북 고창군	45.0%	34.3%	14.2%	40.9%	40.5%

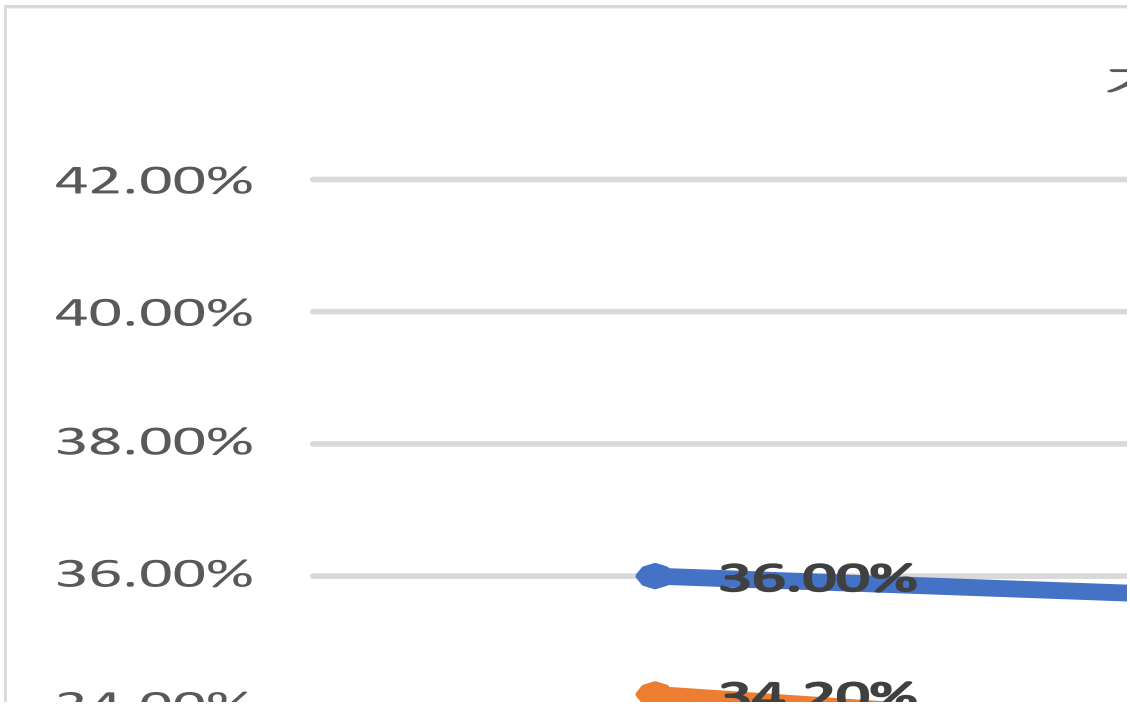
*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

<표 17> 걷기실천율에 따른 중재전략 비교

지역	강원도의 영월군과 삼척시	경상남도의 의령군과 함안군	전라북도 임실군과 고창군
개인	○ 보건영역(전달방식 변화) - 강원건강포럼 성과보고회 개최	○ 보건영역(교육) - 고령인 신체활동 증진프로그램 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 고령인 운동능력평가	○ 보건영역(교육) - 마을 체조교실(지역사업 연계)
개인간			
학교/직장(조직/기관)			
이웃/읍면동	○ 보건영역(교육) - 건강걷기대회 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 인바디 사전-사후검사 - 걷기 평가(걷기속도, 동적 족저압, 골밀도, 악력 검사) ○ 보건영역(전달방식 변화) - 걷기지도자 양성 및 지도자 중심 걷기교실 ○ 사회환경영역(물리적환경) - 산책로 내 야간조명 및 안내판설치	○ 보건영역(교육) - 주민참여를 통한 마을지도그리기 워크샵(1~3차)	○ 보건영역(교육) - 걷기지도자 양성교육 - 마을 단위 걷기실천 자조모임(동아리) ○ 보건영역(전달방식 변화) - 걷기지도자 선정 ○ 사회환경영역(물리적환경) - 마을단위 걷기코스 개발(안내판 설치)
시군구 전체			
효과평가 방법	○ 주민대상 도보환경평가 및 걷기선호도조사결과 비교	○ 1차년도 조사대상자 1500명중 1000명 추적 조사하여 걷기실천율 변화비교	○ 참여대상자 스마트워치 지급을 통한 성과관리

❍ **비만율에 따른 중재전략 검토 결과**

- 강원도의 인제군과 양구군('19-'21년)
  - 、 보건영역 및 이웃/읍면동 위주의 중재전략 시행
  - 、 사업 전후 사업지역과 대조지역의 비만율 격차가 줄어들었으나, 양 지역 모두 비만율이 증가하여, 중재사업의 성과가 있었다고 보기 어려움



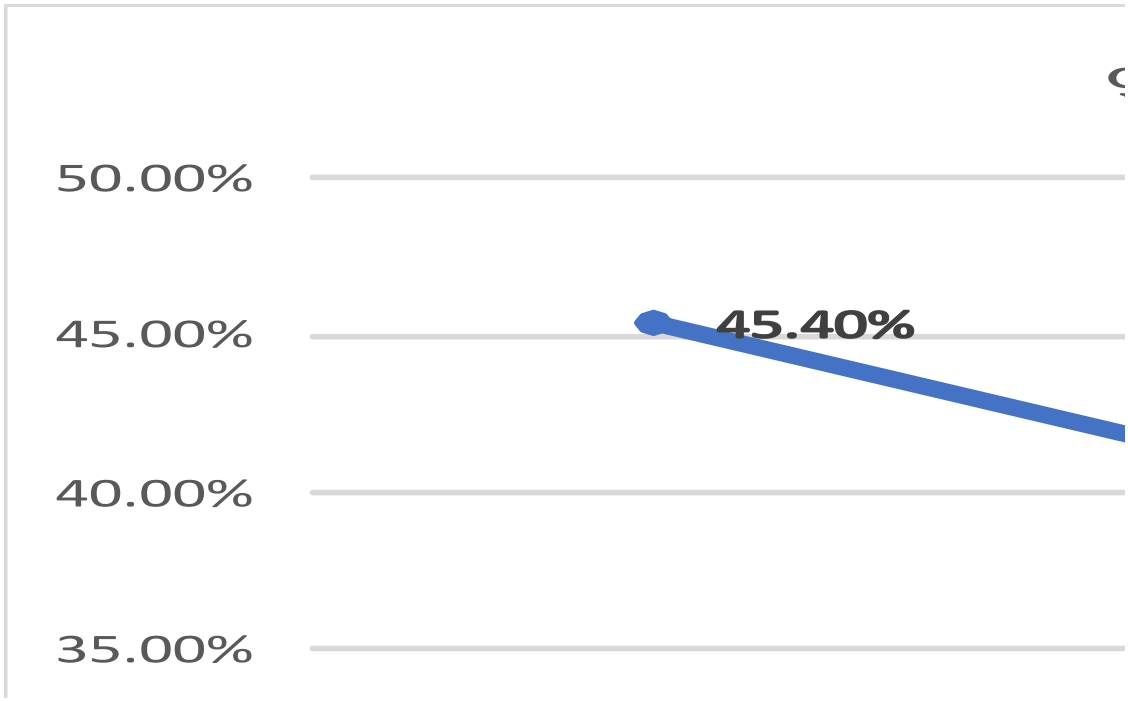
[그림 8] 강원 인제군-양구군 비만율

<표 18> 강원 인제군-양구군 비만율

비만율	2018년	2019년	2020년	2021년*	2022년
강원 인제군	36.0%	-	35.6%	40.2%	39.8%
강원 양구군	34.2%	-	33.5%	40.9%	39.3%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 인천광역시의 옹진군과 부평구('20-'22년)
  - 보건영역의 교육 및 사회환경영역의 물리적환경 위주로 개인, 이웃/읍면동, 시군구 전체 단위의 중재전략시행
  - '22년 종료사업이므로 사업 후 지표확인이 불가능하였으나, 3차 년도까지의 사업지역의 비만율의 감소 및 격차가 감소하는 것으로 나타나 중재사업의 성과가 있었다고 할 수 있음



[그림 9] 인천 옹진군-부평구 비만율

<표 19> 인천 옹진군-부평구 비만율

비만율	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년*
인천 옹진군	45.4%	-	40.3%	38.3%	38.0%
인천 부평구	29.7%	-	33.6%	35.7%	36.5%

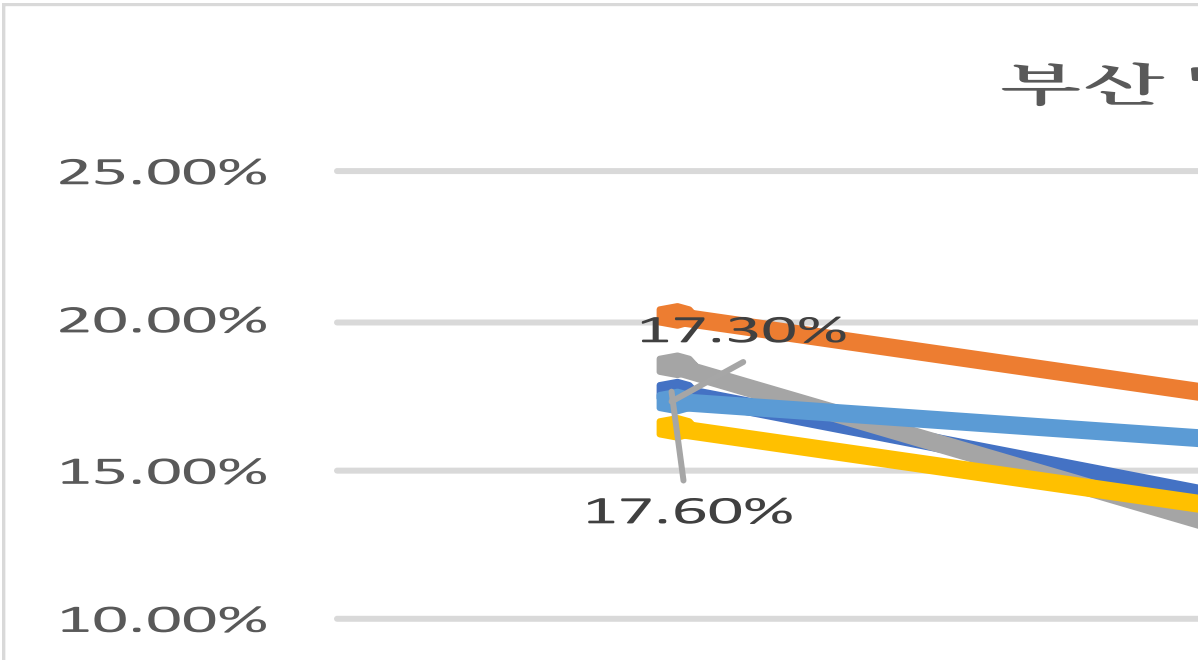
*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

<표 20> 비만율에 따른 중재전략 비교

지역	강원도의 인제군과 양구군	인천광역시의 옹진군과 부평구
개인	○ 보건영역(교육) - 비만인식개선을 위한 사회적캠페인	○ 보건영역(교육) - 농어촌 도서지역 체중조절 및 만성질환 관리를 위한 영양관리 프로그램
개인간		
학교/직장(조직/기관)		
이웃/읍면동	○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 교육프로그램 사전-사후 평가: 설문 체력변화 측정 ○ 보건영역(전달방식의 변화) - 건강지킴이 양성교육 ○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 지역주민 대상 운동프로그램 진행	○ 보건영역(교육) - 주민주도형 가이드라인 계획
시군구 전체		○ 사회환경영역(물리적환경) - 보건지소 건강증진실 등 체육시설 이용
효과평가방법	○ 사회적캠페인평가: 지역소식지 인지에 대한 설문조사	○ 이론 및 실습을 통한 식생활습관 개선교육 ○ 건강리더 양성을 통해 기관과 주민의 필수요소들을 보완하기 위한 교육을 실시

○ **고위험음주율에 따른 중재전략 검토 결과**

- 부산광역시의 동구·중구·서구·영도구와 남구('18-'20년)
  - 보건영역의 중재 및 단위는 개인, 이웃/읍면동, 시군구 전체로 이뤄짐
  - 사업지역의 고위험음주율은 사업 전부터 대조지역에 비해 낮았으나, 사업 전후 사업지역의 고위험음주율은 낮아졌으며, 지표격차 또한 사업지역이 더 크게 나타나 중재사업의 성과가 있었다고 할 수 있음



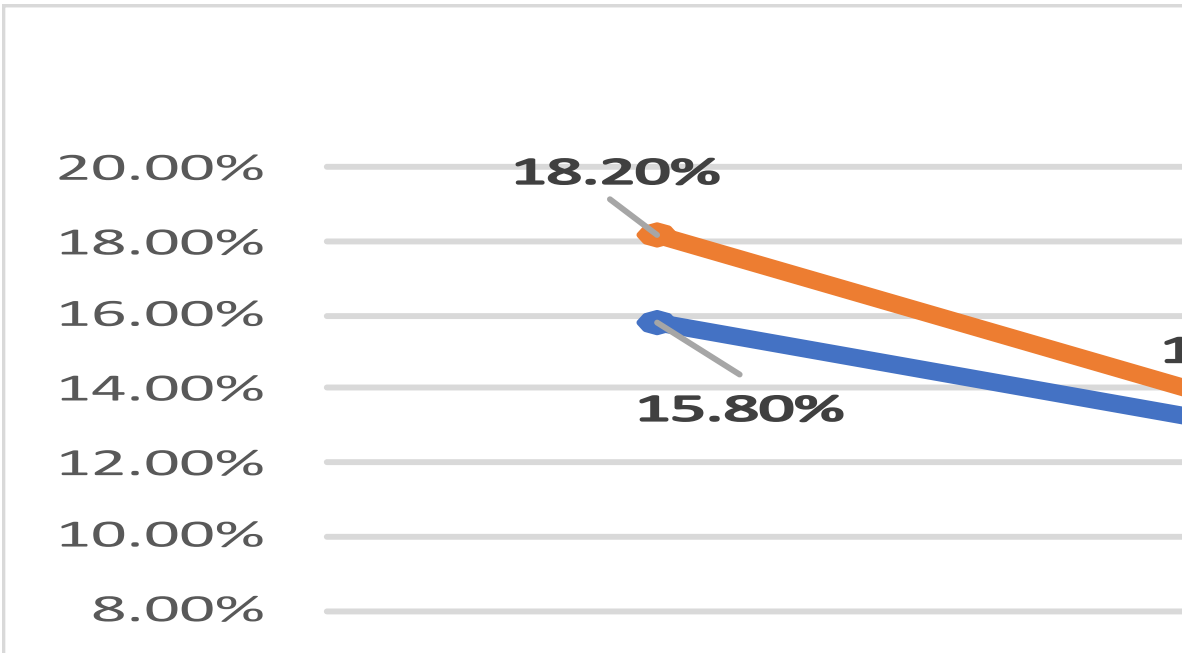
[그림 10] 부산 동구 등-남구 고위험음주율

<표 21> 부산 동구 등-남구 고위험음주율

고위험음주율	2018년	2019년	2020년*	2021년	2022년
부산 동구	17.6%	13.4%	11.4%	11.5%	14.7%
부산 중구	20.2%	17.0%	12.3%	13.3%	12.1%
부산 서구	18.5%	12.0%	10.6%	9.7%	13.7%
부산 영도구	16.4%	13.2%	10.6%	8.8%	16.2%
부산 남구	17.3%	15.8%	10.7%	13.2%	14.0%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- 충청남도의 금산군과 공주시('18-'20년)
  - 보건영역의 중재가 대부분이었으며, 중재단위는 다양하게 분포되어있음
  - 사업지역의 고위험음주율은 사업 전부터 대조지역에 비해 낮았으며, 사업 전후 사업지역의 고위험음주율은 낮아졌음. 그러나, 사업 후 대조지역의 고위험음주율이 사업지역보다 낮게 나타나 중재사업의 성과를 파악하기 어려움



[그림 11] 충남 금산군-공주시 고위험음주율

<표 22> 충남 금산군-공주시 고위험음주율

고위험음주율	2018년	2019년	2020년*	2021년	2022년
충남 금산군	15.8%	12.6%	9.3%	15.0%	9.2%
충남 공주시	18.2%	13.0%	11.4%	13.4%	13.1%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

<표 23> 고위험음주율에 따른 중재전략 비교

지역	부산광역시의 동구중구·서구·영도구와 남구	충청남도의 금산군과 공주시
개인	○ 보건영역(교육) - 절주앱 - 서포터즈 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 고위험음주 단기개입	○ 보건영역(교육) - 서포터즈 - 현장캠페인 ○ 보건영역(스크리닝과 질환예방) - 금연절주통합 상담(보건소 금연클리닉)
개인간		○ 보건영역(교육) - 비대면 절주 릴레이 캠페인 ○ 사회환경영역영역(사회문화적) - 소모임 절주지킴이 활동
학교/직장(조직/기관)		
이웃/읍면동	○ 보건영역(전달방식 변화) - 절주 활동가 양성	○ 보건영역(전달방식 변화) - 절주 활동가 양성
시군구 전체	○ 보건영역(교육) - 홍보물(사회적마케팅) ○ 사회환경영역(정치적_규제) - 기관 네트워크	○ 보건영역(교육) - 홍보물 ○ 사회환경영역(정치적_규제) - 건강생활실천협의회 - 조례 제정
효과평가방법	○ 사업지역과 대조지역 사업전후 비교설문(약300명) ○ 사업지역과 대조지역 지역사회건강조사 지표 사업전후 변화비교	○ 소모임 절주지킴이 활동: 모인 전-후 비교 ○ 사업지역과 대조지역 지역사회건강조사지표 사업전후 변화비교

❍ 그 외 중재전략 검토 결과

- (당뇨병 진단경험률) 광주광역시의 남구와 서구('17-'19년)
  - 보건영역의 개인수준에서의 교육프로그램 중재전략시행
  - 당뇨병 진단경험률로 지표비교를 실시하였으며, 사업 전후 사업지역의 당뇨병 진단경험률은 감소하였으며, 대조지역에 비해 사업지역의 지표가 더 좋아졌으므로, 중재사업의 성과가 있었다고 할 수 있음

<표 24> 광주광역시의 남구와 서구의 당뇨병 진단 경험율

당뇨병 진단 경험률	2018년	2019년*	2020년	2021년	2022년
광주 남구	8.6%	6.2%	6.4%	7.4%	9.9%
광주 서구	5.8%	7.2%	8.0%	9.2%	10.3%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- (중등도 이상 신체활동실천율) 대구광역시의 남구와 동구('19-'21년)
  - 보건영역과 사회환경영역에 고르게 분포되어 있으며 대부분 개인, 이웃/읍면동 단위의 중재전략 시행
  - 사업 전후 사업지역의 중등도 이상 신체활동 실천율은 낮아졌으며, 대조지역과의 격차 또한 더 크게 나타나, 중재사업의 성과는 미미함

<표 25> 대구 남구와 동구의 중증도이상 신체활동실천율

중증도이상 신체활동실천율	2018년	2019년	2020년	2021년*	2022년
대구 남구	-	19.8%	12.8%	14.1%	14.2%
대구 동구	-	24.7%	20.5%	19.7%	25.6%

*사업 종료 연도
자료: 2022 지역건강통계 한눈에 보기(질병관리청, 2023.05)

- (암검진율) 부산광역시의 수영구와 해운대('20-'22년)
  - 보건영역의 교육을 개인 간 단위로 중재전략시행
  - 2차년도에 해당하는 2021년 이후의 자료는 확인할 수 없어 중재사업 성과여부 판단은 하지 않음

<표 26> 기타 중재전략 비교

지역	광주광역시의 남구와 서구	대구광역시의 남구와 동구	부산광역시의 수영구와 해운대
지표	당뇨병 진단경험률	중등도 이상 신체활동실천율	암검진율
개인	○ 보건영역(교육) - 자가관리 역량강화를 위한 병원기반 프로그램	○ 보건영역(교육) - 워크온 앱을 활용한 걷기캠페인 ○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 주민들의 신체활동 요구도조사	
개인간			○ 보건영역(교육) - 암예방검진 역량강화 프로그램 집단교육
학교/직장(조직/기관)		○ 보건영역(교육) - 유아 대상 걷기습관 활동프로그램	
이웃/읍면동		○ 보건영역(전달방식 변화) - 걷기 건강리더 양성교육, 주민참여기반 건강마을사업 ○ 사회환경영역(물리적 환경) - 쉼의자 설치제안 ○ 사회환경영역(사회문화적 환경) - 앞산활용 등산걷기: 주민들 주도적모집 및 장소.시간결정 ○ 사회환경영역(정치적환경_규제) - 대명6동 건강마을 사업단 구성 - 주민자치회(2기) 내 건강행복문과신설	
시군구 전체			
효과 평가 방법	- 영양관리 생활행태 개선 및 의료기관과의 협력 도모	- 주민자치위원/사업참여기관 담당자 대상 포커스그룹 인터뷰	- 검진준비 및 결과 등의 교육을 실시하고 자신의 거주마을 특성을 바탕으로 구체적인 활동계획을 수립하도록 함

라. 종결사업 우수사례 선정

○ 종료사업(14개)를 대상으로 각 사업의 주요 지표에 대한 연도별 추이를 분석하고 사업종료 이후 관련 사업의 추진 현황 등을 종합하여 우수사례를 선정

※ 전북 임실군의 걷기실천율 사업과 인천 옹진군의 비만율 사업의 지표 결과값을 통해 사업의 성과를 확인하였지만 '22년 종료사업이므로 '23년 지역사회건강조사 결과에 따른 추가 평가 필요

<표 27> 종료사업의 주요 지표별 변화

No.	구분		연도	2018년	2022년	격차
1	현재흡연자의 금연시도율	**경기 양평군**	**'17-'19**	**16.3%**	**56.3%**	**40.0%**
2		**전북 김제시**	**'18-'20**	**12.7%**	**34.9%**	**22.2%**
3		서울 동대문구	'19-'21	23.9%	39.5%	15.6%
4		인천 미추홀구	'19-'21	25.4%	31.5%	6.1%
5	걷기실천율	강원 영월군	'17-'19	34.4%	38.7%	4.3%
6		경남 의령군	'18-'20	28.8%	32.0%	3.2%
7		전북 임실군	'20-'22	29.8%	50.3%	20.5%
8	당뇨병	광주 남구	'17-'19	8.6%	9.9%	1.3%
9	비만율	강원 인제군	'19-'21	36.0%	39.8%	3.8%
10		인천 옹진군	'20-'22	45.4%	38.0%	△7.4%
11	고위험음주율	부산 동구·중구·서구·영도구	'18-'20	18.18%	14.8%	△4.0%
12		충남 금산군	'18-'20	15.8%	9.2%	△6.6%
13	중증도이상 신체활동율	대구 남구	'19-'21	19.8% (2019년)	14.2%	△5.6%
14	암검진율	부산 수영구	'20-'22	-	-	-

① 경기 양평군의 현재흡연자의 금연시도율 건강격차 해소사업('17-'19)

- 건강격차 해소사업 중 가장 높은 지표 변화를 보인 경기 양평군은 성공적인 사업 종료 이후에도 지속적으로 금연관련 사업 및 프로그램을 운영중

※ 양평군보건소 금연클리닉 운영을 비롯한 양평군내 17병의원 금연치료지원 실시하고 있음

- 건강격차 해소사업 전에도 양평군은 군민들의 자발적인 금연분위기 조성을 위해 '담배연기 없는 건강한 도시! 양평만들기 실천' 캠페인을 실시하였음

※ 양평군 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례(2012.5.29. 제정)

- 건강한 금연문화 조성을 위해 유아부터 어르신을 대상으로 생애주기별 금연교육 및 캠페인 실시
- 통합건강증진사업 국가금연지원 부문 경기도 우수기관 표창 수상('19년)

② 전북 김제시의 현재흡연자의 금연시도율 건강격차 해소사업('18-'20)

- 전북 김제시는 '금연 명품도시'로 지역사회 금연문화 확산과 금연환경 조성을 위해 많은 노력을 기울이고 있음
- 해당 중재사업을 통해 시민들의 금연에 대한 인식개선을 위한 분위기 조성에 주력하였으며 건강취약지역 소지역 집중 건강캠프 추진과 찾아가는 금연 건강캠프 운영하여 좋은 평가를 받음
- 사업종료 이후에는 지표율의 감소를 보였지만 코로나19상황에서도 비대면 금연클리닉을 운영하며 다양한 금연지원서비스를 실시하는 등 지속적인 사업 운영에 노력
- 건강증진부야 금연사업 우수기관으로 선정 전라북도지사 표창 수상('21년)

○ 종합

- 건강격차 해소사업을 성공적으로 마무리하고 '현재흡연자의 금연시도율'의 지표가 지속적으로 상승할 수 있었던 주요 요인으로는 두 사업을 수행했던 지자체의 적극적인 사업 추진 의지를 확보를 비롯하여 관련 보건자원들을 협력한 것이 사업 성공의 주요인으로 판단됨
  - 타 건강격차 사업중 지표율의 변화는 적었지만 강원 영월군의 걷기실천 사업 또한 사업 종료 이후에도 지자체에서 걷기활성화 조례를 제정('23.5.26)하고, 걷기순례지 등 인프라를 정비·조성하였으며, '강원형 건강증진모델 개발 시범사업'에 응모하여 선정되는 등 사업 종료이후에도 지자체가 걷기 관련 사업을 적극적으로 수행하고 있음

2. 국외 건강격차 해소 우수사례 조사·분석

가. 영국의 건강격차 정책과 사업 현황

1 NHS, Core20plus5 접근법 개발[1)]

○ (목적) 건강격차 해소 목적의 국가적 접근법 개발

○ (내용) 대상 모집단인 'Core20plus'를 정의하고 개선이 필요한 '5'중점의 임상 영역 지정

- Core20
  - 、 전체 인구 중 박탈지수 하위 20% 선정

※ 박탈지수 하위 20% 인구의 빈곤으로 주는 영향을 파악하고 해결

- plus
  - 、 지역 수준에서 plus 인구 집단 선별

※ 지역 안 특정 격차에 추가 초점을 의미하며, 통합 의료 시스템(ICSs)를 통해 격차를 식별하고 해결하고자 함

  - 、 소수 민족 커뮤니티·학습 장애 및 자폐증·노숙인이나 난민 및 알코올 중독자와 같이 건강 서비스 접근이 힘든 그룹 등 사회적으로 배제된 그룹이 포함

- 5 중점 임상영역
  - 、 가속화된 개선이 필요한 5가지 임상 중점 영역 선별한 뒤 지역 시스템 전반에 걸쳐 지원
  - 、 흑인·아시아인·소수 민족 공동체와 가장 빈곤한 집단의 여성에 대한 지속적인 보살핌을 보장하며 출산과 산모를 관리
  - 、 중증 정신 질환(SMI)에 대한 건강검진 매년 실시하고 보장
  - 、 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)에 초점을 맞춰 COVID-19·독감 및 폐렴 백신 접종을 촉진하고 감염 악화 및 악화로 인한 응급 입원 감소
  - 、 조기 암 진단으로 2028년까지 암 진단 사례의 75%가 1기 또는 2기에서 진단 목표 설정

1) The King's fund (https://www.kingsfund.org.uk/blog/2021/12/nhs-england-and-tackling-inequalities)

❍ (사례1) 런던 람베스(Lambeth) 지역의 건강 격차 해소 프로그램 시행[2)]

- (목적) 람베스 지역의 흑인·소수민족과 백인 사이의 고혈압 비율 격차 감소
- (내용) 흑인·소수민족의 고혈압을 발견하고 관리하는 12개월 프로그램 실시
  - 아프리카 흑인·카리브 해 흑인·백인 환자로 대상 집단 선정
  - 프로그램 시작 당시 80세 미만의 고혈압 관리를 받고 있는 백인은 67% 흑인은 55%로 12%의 격차 발견
  - 일반의와 일차의료 네트워크 관리자(Primary Care Network manager)의 주도 하에 운영
  - 인구 건강관리 데이터 플랫폼인 EZ Analytics를 통해 위험 환자를 식별하고 진행 상황을 모니터링 하여 모든 고혈압 환자들의 혈압 조절 개선에 초점
  - 고혈압 환자들에게 지속적으로 연락을 유지하며 적극적으로 검사 실시
- (결과) 80세 미만의 모든 환자 중 87%가 안정적으로 혈압을 관리 중이며 전년도 대비 61% 상승했으며 80세 이상의 경우 95%가 안정적으로 혈압을 관리 중으로 전년도 대비 77% 상승

❍ (사례2) 상대적 박탈 지역 거주 아동의 병원 무료 운송 프로그램 시행[3)]

- (목적) 상대적 박탈 지역 거주 아동의 병원 예약 후 미방문율 감소
- (내용) 병원 예약을 한 아동이 병원에 갈 수 있도록 맞춤형 운송 지원 프로그램 실시
  - 진료 예약과 방문까지 소요되는 금액 문제로 빈곤지역 가정의 경우 의료 서비스 접근에 곤란
  - 또한 병원 예약 후 미방문 건수가 매년 30,000건 이상으로 경제적 손실 발생을 파악
  - 빈곤 지역의 아동들이 병원 예약 후 방문할 수 있도록 하는 맞춤형 운송 지원 프로그램 실시하여 운송 지원 및 병원 부지 무료 주차 또는 대중교통 이용권 등 지원
- (결과) 병원 예약 후 미방문율 감소 및 예약 재조정 건수 140건 이상 달성하였으며 현재 2400 가정에 무료 운송 서비스 제공중

---

2) NHS 홈페이지 (https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/case-studies/how-lambeth-is-closing-the-health-inequality-gap-for-black-and-minority-ethnic-patients-with-high-blood-pressure/)

3) NHS 홈페이지 (https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/case-studies/free-transport-reduces-was-not-brought-rates-for-children-at-midlands-trust/)

2 스피어헤드(spearhead) 그룹 선정[4)]

○ 건강 격차에 대응하기 위한 정책 목표 마련

- 건강 수준이 낮고 결핍 정도가 심한 지역을 스피어헤드 그룹(spearhead group)으로 별도 선정하여 정책의 중점 대상 집단으로 설정
- 정책 목표를 “2010년까지 건강 수준이 가장 열악하고 물질 결핍 수준이 가장 심한 하위 20% 지역과 나머지 지역 간의 출생 시 기대여명 격차를 적어도 10% 감소시킨다”로 구체적으로 설정
- 정책 설정 당시 정책의 주요 대상이 된 스피어헤드(spearhead) 지역은 영국 전역 70개 지역으로 선정함

○ 스피어헤드 그룹(spearhead group)

- 스피어헤드 지역은 잉글랜드 전체 평균보다 낮은 수준의 일반의를 보유하고 있으므로 일반의 진료소 112개를 추가 설치함
- 스피어헤드 지역의 조기사망률을 낮추는 가장 비용효과적인 방법으로 세 가지 중재 방안 제안
  - 、 금연 서비스를 통한 금연 성공자 증가
  - 、 심혈관질환을 진단 받은 환자 혹은 심혈관질환 발병 위험이 높은 사람들에 대한 혈압강하제 투여율 제고
  - 、 심혈관질환을 진단받은 환자 혹은 심혈관질환 발병 위험이 높은 환자에 대한 스타틴(콜레스테를 저하제) 투여율 제고

○ 스피어헤드 그룹에 대한 평가

- 스피어헤드 지역에서의 금연 사업 성과를 모니터하기 위해 건강불평등 중재 툴킷 개발하여, 금연사업의 성과를 건강불평등 관점에서 평가하도록 함

4) 지역 간 건강불평등 해소를 위한 영국의 대응 정책 분석과 함의 고찰(한국보건사회연구원, 2017)

나. 일본의 건강격차 정책과 사업 현황

1 국토교통성 건강·의료·복지 마을 만들기 추진 가이드라인 제정[5)]

○ (배경) 전 세계적으로 유례가 없는 초고령 사회로, 2055년에는 인구의 30%가 감소하고 65세 이상 인구가 총 인구의 40%에 육박할 것으로 예측

○ (목적) 건강, 의료, 복지의 시점에서 필요한 사업이나 시책을 목적으로 가이드라인을 제정함

<건강한 도시 만들기 가이드라인>
(1) 나가고 싶어지는 거리가 정비되어져 있다.
(2) 거리를 (또는 거리를 즐기는 것에 의해) 자연스럽게 걷는다.
(3) 목적지로의 이동에서 공공교통이 편리하게 정비되어져 결과적으로 걷게 된다.

○ 가이드라인에 따른 우수도시 사례

- 니가타현 미쓰케시, 오사카 다카이시시, 교토 야와타시, 오사카부 다카이시시

<표 28> 국토교통성 우수 건강 도시 선정과 선정 이유

선정 도시	선정 이유
니가타현 미쓰케시	미쓰케시내 부서간 협업으로 긍정적 효과를 이뤄낸 사례
아이치현 오카자키시	기존 도시 정책과 연계하여 건강정책을 수행한 사례
교토부 야와타시	건강증진계획에 '도시정책'을 포함시킨 사례
오사카부 다카이시시	인프라 구축으로 교육을 결합해 걷기를 추진한 사례

출처: 국토교통성 홈페이지 (https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001616190.pdf)

○ **(사례1) 니가타현 미쓰케시(新潟県見附市)**

- (목표) 거주만으로 자연히 걷게 되는 '건강도시(일본식 표기: 스마트웰네스시티)' 조성
- (중점 사업 내용) 건강무관심층의 개선, 걷고 싶어지는 환경정비, 주민조직을 포함한 인재의 육성 등
  - 、 인프라 정비로 사람들이 모일 수 있는 장소 정비
  - 、 프로그램 사업으로 사람들이 모여서 교류를 할 수 있도록 촉진
  - 、 대중교통망을 정비하여 노선버스 및 마을버스 등을 전략적으로 다듬어 마을버스의 경우 이용객 수가 2006년 연간 약 5만명에서 2019년 18.5만명까지 확대

5) 국토교통성 홈페이지

- 지역커뮤니티조직, 시민문화센터, 시민 갤러리 등을 설치
- 도시 만족도 상승 및 건강보험비용 억제 효과 등 발생



자료: 국토교통성 홈페이지

[그림 12] 니가타현 미쓰케시의 건강도시 정책 사례

○ (사례2) 오사카 다카이시시(大阪府高石市)

- (목표) 저절로 건강과 행복이 이어지는 '건행(健幸)거리'(이하 '건강')의 실현
- (중점 사업 내용) 자율적으로 '걷는 것'에 의하여 건강하고 행복한 '건강 마을꾸미기'를 실현하는 '건강도시'를 도입하여 제4차 다카이시 종합계획을 수립하고 시청내 보건복지부서 건강만들기과 건강도시추진반을 창설
  - 4차선 도로를 2차선으로 축소한 '건강' 워킹로드를 정비(폭이 넓은 도보와 자전거도로를 정비)

<표 29> 스마트웰네스시티 다카이시 기본계획

목표	과학적인 근거 기반의 건강정책의 추진	'걷고 싶어지는, 걷게 되는' 거리 만들기
◦ 시가 실시하는 '시민 건강증진 사업'의 참가자수 1,000명 이상 ◦ 일일 평균 걸음 수 9,000보 달성자 비율이 현황의 30% 이상으로 증가 ◦ 국민건강보험에서 의료비 약 2억엔 억제	◦ 성과가 보이는 개별운동 및 영양 프로그램으로 건강증진 ◦ 과학적 근거에 기반한 건강정책 제정 및 정책 추진을 위한 시스템화	◦ 건강증진 커뮤니티의 장 창출 ◦ 보행자 전용 공간의 창출 ◦ 걷고 싶은 거리 정비

출처: 국토교통성 홈페이지 (https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001616190.pdf)

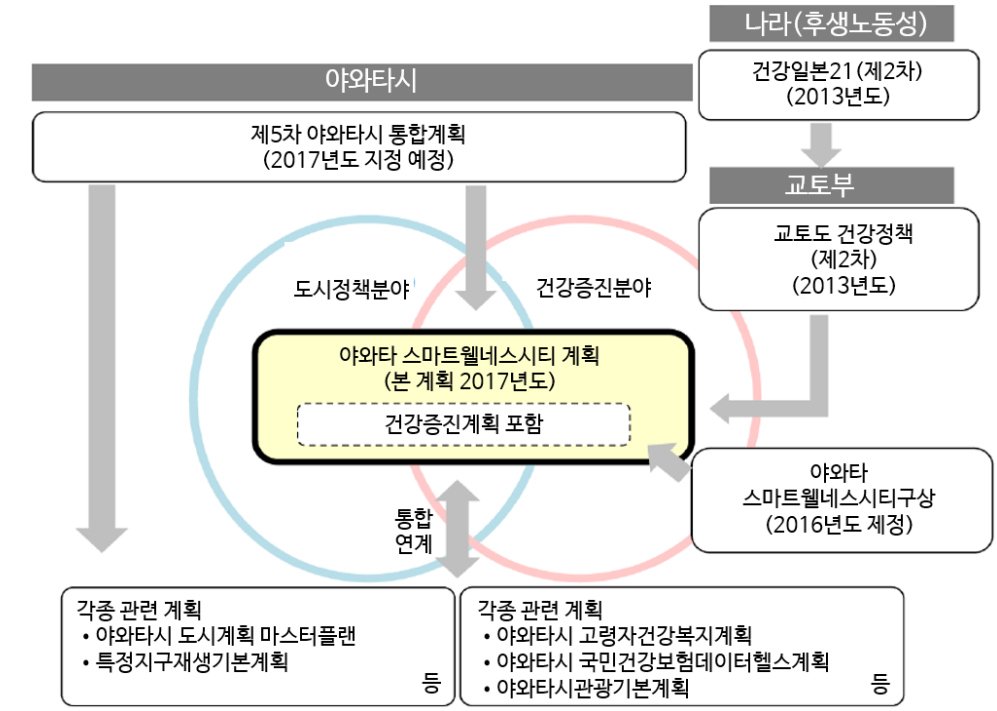


자료: 국토교통성 홈페이지

[그림 13] 오사카 다카이시시의 건강한 도시만들기

○ (사례3) 교토 야와타시(京都府八幡市)

- (목표) 건강을 시책의 기둥으로 건강수명을 연장시키고 복지에 들어가는 세금을 억제하는 것을 목표로 함
- (중점 사업 내용) 도시정책과 건강정책이 하나가 된 '야와타 스마트웰네스시티 계획'



출처: 국토교통성 홈페이지 (https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001616190.pdf)

[그림 14] 야와타시 건강도시 정책 진행 구성

- 개인의 편리함만을 지나치게 추구하지 않는 라이프 스타일에의 전환과 (건강무관심층을 타겟으로 하는 등) 자연이나 역사문화를 활용한 걷고 싶은 거리에의 전환이라는 두 가지 목표를 설정
- 2019년부터는 걷기 실천이나 인바디 측정 및 건강검진을 받는 사람에게는 포인트(최대 6천엔)가 제공되는 '야와타 미래 씩씩 건강 프로젝트'(인센티브)사업을 시작
- 건강무관심층이 즐기면서 노력할 수 있도록 사업을 실시하여 2023년 3월까지 약 4,000명이 참가하였으며, 비참여자와 비교해 사업 참여자의 인당 의료비와 요양비용이 21만엔 감소하였음



자료: 국토교통성 홈페이지

[그림 15] 교토 야와타시의 건강한 도시만들기

2 일본 스마트웰네스시티수장연구회 (スマートウエルネスシティ首長研究会)

○ (설립 배경) 2002년 일본 최초 건강증진분야 대학 기반 컨설팅 기업 ㈜쯔쿠바웰네스리서치((株) つくばウエルネスリサーチ)를 설립

- '건강 도시'의 비즈니스화의 필요성 부각되어 비즈니스 모델 창출
- 전국 지자체 및 기업 등을 활용하여 건강증진 프로그램 등을 개설하고 서로 협력하는 네트워크를 구축하고 지원하고자 함

○ (설립 취지) 지자체의 건강정책이 시민 전체를 위한 대응하도록 개선

- 기존 지자체의 건강정책은 공중위생 중심으로 시민 전체 대응 불가
- 검진 중심의 예방 정책은 이하와 같은 기존 문제 해결하기에는 미흡함
  - 、 검진으로 드러난 대상자가 보건지도나 요양예방사업에 참가하지 않는 문제
  - 、 지자체가 실시하는 중장년 대상 건강교실 참가자는 건강 상태가 비교적 양호하고 의료비 지출이 크지 않은 문제

❍ (목표) 건강 관심층 뿐만 아니라 시민 누구라도 참가하여 성인병 및 와상 상태를 예방할 수 있는 건강 마을을 조성하고자 함

<스마트웰네스시티수장연구회의 '건강 마을 만들기' 정의>
- 외출하고 싶은 마을의 조성
- 마을을 자연스럽게 걷기 실천
- 목적지까지 대중교통이 편리하게 정비됨에 따라 걷기 실천

❍ (주요사업) 과학적 근거에 따라 이하의 '건강 마을 만들기'사업을 지자체 연계로 3년간 추진[6)]

- 건강하고 바람직한 생활로 이끄는 교육의 충실
- 건강의 관점에서 마을의 미적 경관 및 보도나 자전거 도로 또는 공원 정비 추진
- 건강의 관점에서 도시교통망 및 상점가를 조성
- 밤에도 걸을 수 있는 치안 유지 및 강화
- 건강 조성의 관점에서 지역생산 지역소비가 가능한 농업 등을 추진
- 지역의 건강조성 네트워크를 지원하는 첨단 건강 서비스 산업 육성
- 그 외 세계에서 아직 확립되지 않은 '저출산 고령화·인구 감소 사회'를 극복하는 마을 'Smart Wellness City'의 구체적인 방안을 창고 및 구축
- 그 외 연 2회 연구회 실시, Smart Wellness City 대상 설립, 나라에 정책 제언

❍ (운영) 전국의 선진적인 행동을 취하고 있는 가맹 지자체의 시장들이 연구회 주축

- 건강 도시의 비즈니스를 구축하고 가속화하기 위해 2009년 스마트웰네스시티수장연구회 출범 후 ㈜쯔쿠바웰네스리서치는 사무국을 담당
- 현재 스마트웰네스시티 수장연구회 가맹 지자체는 125개소

6) 건강마을만들기의 사례집(健康まちづくりの事例集)

3 후생노동성 건강일본21(3차) 계획

❍ (배경) 기존의 '국민 건강 증진의 종합적인 추진을 계획하는 방침(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針)'(이하 '건강일본21') 사업 개정

- 2000년 후생노동성 건강일본21 1차 방침 첫 발표
- 2013년 생활습관을 개선하고 성인병의 발병을 예방하기 위해 건강일본21 2차 개정안 발표
- 2023년 저출산 고령화에 따른 총인구 및 생산연령인구의 감소 등과 같은 생활양식 변화에 대응하기 위해 3차 개정안 발표

❍ 건강일본21 3차 개정에서 이하와 같은 구체적인 목표 지정

- 건강수명의 연장과 건강격차의 축소

<표 30> 건강수명의 연장과 건강격차의 축소 목표

목표	지표	목표치
건강수명의 연장	일상생활에 제한이 없는 기간의 평균	평균 수명의 증가분을 웃도는 건강수명의 증가
건강격차의 축소	일상생활에 제한이 없는 기간의 평균 중 하위 1/4인 지자체의 평균	일상생활에 제한이 없는 기간의 평균 중 상위 1/4 지자체의 평균 증가분을 웃도는 하위 1/4의 지자체 평균 증가

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

- 개인의 행동과 건강상태의 개선
  - 생활습관 개선에 대한 구체적인 목표 지정

<표 31> 영양·식생활 개선 목표

목표	지표	목표치
적정체중을 유지하고 있는 자의 증가 (비만, 저체중의 젊은 여성, 저영양경향의 고령자 감소)	BMI 18.5 이상 25 미만 (65세 이상은 BMI 20 초과 25 미만) 의 비율 (연연령 조정값)	66% (2032년)
아동청소년의 비만경향 감소	아동청소년의 비만경향 비율	2023년부터 개시하는 제2차 성장발달의료 등의 제공에 관한 행정규칙의 종합적인 기본 방침(이하 '제2차 성장발달의료등기본방침')에 맞춰 설정

목표	지표	목표치
밸런스가 좋은 식사를 섭취하는 자의 증가	주식·메인·반찬을 조합한 식사가 1일 2회 이상인 날이 거의 매일인 자의 비율	50% (2032년)
야채섭취량의 증가	야채섭취량의 평균치	350g (2032년)
과일섭취량의 개선	과일섭취향의 평균치	200g (2032년)
염분섭취량의 감소	염분섭취량의 평균치	7g (2032년)

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

<표 32> 신체활동·운동 개선 목표

목표	지표	목표치
일상생활 걸음 수 증가	1일 걸음 수 평균치 (연령 조정값)	7,100보 (2032년)
운동습관을 가진 자의 증가	운동습관을 가진 자의 비율	40% (2032년)
운동이나 스포츠를 습관적으로 가지 않는 어린이의 감소	일주간 총 운동시간(체육수업 제외)이 60미만인 아동의 비율	제2차 성장발달의료등기본방침에 맞춰 설정

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

<표 33> 휴식·수면 개선 목표

목표	지표	목표치
수면으로 휴식을 취하고 있는 자의 증가	수면으로 휴식을 취하고 있는 자의 평균치	80% (2032년)
수면시간이 충분히 확보 가능한 자의 증가	수면시간이 6~9시간 (60세 이상은 6~8시간)의 자의 비율 (연령 조정값)	60% (2032년)
노동시간이 주당 60시간 이상의 노동자 감소	노동시간이 주당 40시간 이상인 노동자 중 노동시간이 주당 60시간 이하의 노동자 비율	5% (2025년)

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

<표 34> 음주 개선 목표

목표	지표	목표치
성인병의 위험을 높이는 음주를 하고 있는 자의 감소	하루에 순수 알코올 섭취량이 남성 40g 이상, 여성 20g 이상인 자의 비율	10% (2032년)
20세 미만인 자가 음주를 하지 않는 것	중학생·고등학생의 음주자 비율	0% (2032년)

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

<표 35> 흡연 개선 목표

목표	지표	목표치
흡연률의 감소	20세 이상인 자의 흡연률	12% (2032년)
20세 미만인 자가 흡연을 하지 않는 것	중학생·고등학생의 흡연자자 비율	0% (2032년)
임신 중에 흡연을 하지 않는 것	임산부의 흡연률	제2차 성장발달의료등기본방침에 맞춰 설정

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

- 사회환경의 질 향상

<표 36> 사회와의 연결·마음 건강 유지 및 향상에 대한 개선 목표

목표	지표	목표치
지역 사람들과의 유대감을 강하게 느끼는 자의 증가	지역 사람들과의 유대감을 강하게 느끼는 자의 비율	45% (2032년)
사회활동을 하고 있는 자의 증가	어느 사회활동(취직, 취학을 포함)을 하고 있는 자의 비율	기준선으로부터 5% 증가 (2032년)
지역 등에서 다른 사람과 식사를 하고 있는 자의 증가	지역 등에서 다른 사람과 식사를 하고 있는 자의 비율	30% (2032년)
정신건강 대책을 세우는 사업장의 증가	정신건강 대책을 세우는 사업장의 비율	80% (2027년)
'마음의 지지자'의 수*	마음의 지지자의 수	100만인 (2033년)

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

* 후생노동성 사업 중 하나로 정신건강의 기초지식이나 듣는 기술 등을 배우는 프로그램 연수를 수강한 사람을 지칭

<표 37> 자연스럽게 건강해지는 환경 조성 개선 목표

목표	지표	목표치
'건강하고 지속 가능한 식사 환경 조성을 위한 전략적 이니셔티브'의 추진*	'건강하고 지속 가능한 식사 환경 조성을 위한 전략적 이니셔티브'에 등록되어있는 지자체의 수	47 도도부현 (2032년)
'편안해서 걷고 싶어지는' 거리 조성에 노력하는 지자체의 수 증가**	체재 쾌적성 향상구역 ('걷고싶은 거리')를 설정하고 있는 지자체 수	100개소 (2025년)
원치 않는 수동적 흡연 기회를 경험한 자의 감소	원치 않는 수동적 흡연(가정·직장·음식점)의 기회를 경험자의 비율	원치 않는 수동적 흡연이 없는 사회의 실현(2032년)

출처: 후생노동성 홈페이지 (https://www.mhlw.go.jp/content/001102474.pdf)

* 후생노동성 사업 중 하나로 모두가 건강한 식생활을 영위할 수 있도록 식품과 정보의 접근을 양방향에서 할 수 있도록 상호 정비하는 시스템

** 국토교통성 사업 중 하나로 인구감소로 문 닫은 상점가로 지역의 활력 저하가 우려되는 도시의 매력을 향상시키는 사업

3. 지역사회 건강격차 해소사업 추진 기술지원

○ (목적) 지역 간 건강격차 해소사업 연구 수행기관간 원활한 사업 추진을 목적으로 기술지원체계를 마련하고자 함

○ (연구수행체계) 現사업기관 연구자*대상 네트워크 구축 및 운영

*사업수행기관(연구기관)

사업 수행기관	자문 및 기술지원 >>>>	지역 간 건강격차 해소사업 수행기관
㈜테크노베이션파트너스		사업수행기관(연구기관)

[그림 16] 연구자 대상 네트워크 구축

○ (기술지원추진 방법) 現사업기관 대상 기술지원 및 자문

- 사업 추진 단계별 중점 내용에 대한 기술지원 및 자문

<수행 절차>
(1) 기술지원 및 자문에 대한 조사를 통한 수요 파악
(2) 수요결과에 따른 프로그램 개발 및 운영

○ (추진 일정)

- 現사업기관 연구자*대상 수요조사 실시(10월말~11월초)
  、 희망 기술지원 파악(분야 컨설팅 전문가 매칭 또는 자문단 운영 등) 등 기술지원에 대한 의견 수렴
- 기술지원 프로그램 운영(11월중)
  、 기술 수요에 맞는 프로그램 개설 및 운영 예정
- 기술지원 종료(11월말)

4. 지역사회 건강격차 해소 보건사업 추진 매뉴얼 개발

❍ 개요

- (목적) 지역사회의 건강격차 해소를 위한 보건사업 추진 매뉴얼 개발
- (중점 고려 사항)
  - 건강격차 해소사업 추진 절차 및 각 절차별 중점 고려 및 참고사항, 예시 등 포함하여 내용 기술
  - 종결사업 중재모델 타지역 적용을 위한 고려사항 및 지역보건사업 연계 등 활용성 및 사업 적용성 등 정리
- (매뉴얼 이용대상자) 지역 보건의료 담당자 및 건강격차 해소사업 연구자 등
- (매뉴얼 개발 추진 절차)
  - 국내외 건강격차 관련 선행연구 검토를 통해 매뉴얼 목차(안) 마련('23.10~11월)
  - 발주처 검토 및 협의('23.11월중)
  - 매뉴얼 초고 마련('23.11월말~12월초)
  - 전문가 의견수렴을 통한 보완 및 전문성 제고('23.12월초)

제2장 연구용역사업의 진척도

○ 워크샵 일정이 당초 11월에서 12월로 변경됨에 따라 '지역 간 건강격차 해소사업 성과 확산을 위한 홍보' 부문은 12월까지 연장하여 진행 예정

○ (연구 추가 및 수정 사항) 국내외 건강격차 해소를 위한 우수사례에 대한 조사 및 검토를 통해 본 사업에 적용 가능한 중재사업 등을 선정하여 매뉴얼에 적용하고자 함

- 보고서 작업은 10월부터 추진중(당초 12월 추진)

<표 38> 월별 추진 일정

구분	월별 추진 일정					진도율
연구사업내용	8	9	10	11	12	
종결사업 대상 지역 간 건강격차 해소사업 성과분석						100%
성과분석 토대 우수사례 선정사유 마련 및 우수사례 선정						100%
(추가) 국내외 지역 건강격차 해소를 위한 사례 조사·분석						40%
지역 간 건강격차 해소사업 성과 확산을 위한 홍보						30%
현행 지역 간 건강격차 해소사업 수행기관 대상 기술지원 및 자문						5%
지역사회 건강격차 해소를 위한 중재사업 추진 매뉴얼 개발						5%
지자체 맞춤형 기술지원체계 마련 및 시범 운영						-
보고서 작성						30%

▭ : 당초 계획, ▨ : 추가 및 수정된 계획

제3장 과제수행에 따른 문제점 및 개선방안

○ 해당사항 없음

제4장 연구 분담표

구 분	성명	소속	직위	참여율(%)	분 담 내 용
책임연구원	현재호	혁신사업본부	대표이사	30	◦ 성공사례의 발굴 및 홍보 확산 - 국내외 문헌조사(성공요인 조사) - 국내 종료프로젝트에 대한 우수사례 조사 - 우수사례집 작성 및 홍보 확산
연구원	하미함	혁신1팀	책임연구원	30	◦ 사업에 대한 기술지원체계 구축 및 운영 - 기술적 니즈 조사 - 기술지원체계 구축 - 기술지원체계 운영
	김형은	공공2팀	선임연구원	30	◦ 매뉴얼 마련 및 보급 확산 - 유사분야 국내외 매뉴얼 조사 - 건강격차정책사업 추진매뉴얼 작성 기본 설계 - 업무 매뉴얼 마련 및 개선
연구보조원	오현주	혁신3팀	선임연구원	30	◦ 성공사례의 발굴 및 홍보 확산 - 국내외 문헌조사(성공요인 조사) - 국내 종료프로젝트에 대한 우수사례 조사 - 우수사례집 작성 및 홍보 확산
	허제	혁신3팀	전임연구원	30	◦ 사업에 대한 기술지원체계 구축 및 운영 - 기술적 니즈 조사 - 기술지원체계 구축 - 기술지원체계 운영
	배수진	공공1팀	선임연구원	30	◦ 매뉴얼 마련 및 보급 확산 - 유사분야 국내외 매뉴얼 조사 - 건강격차정책사업 추진매뉴얼 작성 기본 설계 - 업무 매뉴얼 마련 및 개선

제5장 중요 연구변경 사항 등 기재

❍ 연구 내용 변경 사항

- 착수보고('23.8월)에서 질병청(만성질환관리과)과 협의한 사항
  - 연구책임자를 대상으로 하는 세미나의 경우 선행연구에서 수행하였으므로 2회 이상 사업 참여자를 대상으로 하는 심층인터뷰로 변경함

<표 39> 주요 연구 내용 변경 사항

당초	변경	비고
사업설명회 및 지자체 실무자 간담회, 사업 성과확산을 위한 홍보	건강격차 해소사업 워크샵 프로그램으로 통합하여 추진	질병청 과업 내용
지자체 맞춤형 기술지원체계 마련 및 시범 운영		
연구책임자 세미나 실시	장기 사업참여 연구책임자 대상 심층인터뷰 추진	테크노베이션 제안내용

제6장 연구비 집행 내역

비목	세목	세세목	계약금액(원)	집행금액(원)	잔액(원)	비고
인건비	①인건비	책임연구원	11,364,288	6,818,574	4,545,714	
		연구원	17,427,970	10,456,782	6,971,187	
		연구보조원	11,650,008	6,990,005	4,660,003	
			5,376,926	3,226,155	2,150,771	
		보조원	4,368,900	2,621,340	1,747,560	
직접비	②여비	국내여비	2,100,000	0	2,100,000	
		국외여비	0	0	0	
	③전산처리비	전산처리비	0	0	0	
	④시약 및 연구용재료비	시약 및 연구용재료비	0	0	0	
	⑤연구활동비	회의비	12,550,000	750,000	11,800,000	
		임차비	2,400,000	0	2,400,000	
		기술정보활동비	0	0	0	
		유인물비	450,000	0	450,000	
		위탁정산수수료	366,000	0	366,000	
	⑥연구과제추진비 (∑①~⑤ 5%이내)		180,000	0	180,000	
	⑦부가가치세(연구비총액/11)		7,863,636	7,863,636	0	
간접비	일반관리비(∑①~⑦ 6%이내)		3,579,939	3,579,939	0	5.2%
연구비 총액			**86,500,000**	**49,128,764**	**37,371,236**	